

意義為中心之線上介入方案對產後婦女母職角色達成與心理健康之成效：一項結合自我慈悲與同儕支持之隨機對照試驗

後設資料

想法編號: seed-theory-5=>2=>1=>1

新穎度: 33.2%

最大相似度: 66.8% (近似於: “[The Effects of a Mobile Application Social Support Program on Postpartum Perceived Stress and Depression].”)

群集: 3

競賽得分: 4 勝

方法論契合度: 3/5

Methodology Reasoning: RCT with online program, measures maternal stress, confidence, competence, and social support, but uses experimental design and includes meaning-centered components not in target methodology.

問題陳述

產後時期是婦女生命中極具挑戰性的轉折點，不僅需要適應新生兒的照護需求，還要重新定位自我角色與身分認同。台灣產後婦女常面臨社會支持隨時間遞減、母職壓力於產後一個月達高峰，以及母育信心與能力發展不均衡等問題。尤其在高齡產婦比例攀升（台灣平均生育年齡已達 35 歲）、家庭結構小型化、以及傳統坐月子文化受到現代生活型態衝擊的背景下，許多婦女在產後早期感受到孤立無援，進而增加產後憂鬱症的風險（盛行率約 10-20%）。現有研究已證實，社會支持、母育信心與能力是緩解母職壓力的重要保護因子，但這些因子在產後四個月的動態變化中，卻呈現社會支持持續下降、壓力於第一個月攀峰的趨勢。更重要的是，現行產後護理措施多集中於生理恢復與嬰兒照護技能指導，對心理層面（如意義感、自我慈悲）的介入相對缺乏。因此，發展一個能同時強化內在資源（意義感與自我慈悲）與外在資源（同儕支持）的線上介入方案，以提升母職角色達成（Maternal Role Attainment）並促進心理健康，是當前產後護理領域亟需解決的重要問題。

現有方法

現有方法主要包括：1) 標準產後護理（如母乳哺育指導、育兒技巧示範、產後憂鬱篩檢與轉介），但此類方法偏重知識傳遞，缺乏情感支持與心理賦能。2) 面對面支持團體（如媽媽教室、哺乳支持聚會），但參與率受地理限制、時間衝突與社交焦慮影響，且台灣全職媽媽或高齡產婦往往難以規律出席。3) 線上育兒論壇或社群媒體群組（如 BabyHome、PTT 媽寶版），提供便利的同儕交流，但缺乏專業引導，容易出現錯誤資訊、比較心態或負面情緒蔓延，且無結構化介入以提升意義感或自我慈悲。4) 正念減壓（MBSR）或認知行為治療（CBT）介入，雖然對產後憂鬱有效，但多數研究集中於憂鬱症狀的治療，而非預防性促進母職角色達成，且課程長度長（8-12 週）、師資需求高，難以大規模推廣。5) 意義治療相關介入，在安寧療護或慢性疼痛領域已有成效，但應用於產後婦女的研究極為罕見。這些方法的共同限制是：未能整合內在資源（意義、自我慈悲）與外在資源（同儕支持）；缺乏對產後不同時間點（如 1、3、6 個月）的縱貫性評估；以及無法針對個人化需求（如產次、嬰兒健康狀況）進行動態調整。

研究動機

現有方法之所以不足以解決問題，主要因為它們僅處理單一層面：要嘛只提供知識（標準護理），要嘛只提供社交互動（論壇），要嘛只治療症狀（CBT）。然而，產後婦女的心理需求是多元且動態的。根據 Frankl 的意義治療理論，當個體在困境中發現意義時，更能忍受痛苦並展現韌性；而自我慈悲（Neff, 2003）則能幫助婦女對抗產後常見的自我批評與完美主義（如「我是不是好媽媽？」）。本提案的靈感來自於：1) 在臨床實務中觀察到，許多婦女在產後感到「失去自我」，若能幫助她們重新連結產後新角色

與個人生命意義的關聯（如「成為母親如何豐富我的人生？」），將能提升角色接納度。2）自我慈悲訓練（如正念呼吸、慈心冥想）已被證實可降低壓力反應，且適合線上傳遞。3）同儕支持若能基於相似性（如同樣照顧高需求嬰兒）經由 AI 配對，能提供更具共鳴的經驗分享。本方案將三者整合成一個 6 週結構化線上課程，每週包含：觀看 10 分鐘教學影片、完成 5 分鐘意義反思日記、進行 10 分鐘自我慈悲練習（如慈悲身體掃描），並加入一個由 4-6 位相似背景婦女組成的私密社團，每週有主題討論（如「當我感到挫敗時…」）。這與現有方法的差異在於：它主動培養內在資源（意義與慈悲），同時透過結構化同儕互動強化外在支持，理論上能更全面地緩解社會支持下降的趨勢，並加速母育信心與能力的發展。

提出方法

本提案提出一個「意義-慈悲-連結」三合一線上介入方案，分為以下步驟：

****方案概述****：設計一個為期 6 週、每週約 30 分鐘的線上課程，透過專屬 App 或網頁平台實施。參與者被隨機分派至介入組或等待對照組（6 個月後提供相同課程）。介入組每週完成一個模組，內容包含：A) 意義練習（基於 Logotherapy，如「書寫一封給未來寶寶的信」）；B) 自我慈悲訓練（基於 MSC，如「自我慈悲暫停」練習）；C) 同儕小組討論（每組 4-6 人，由 AI 根據產次、嬰兒健康狀況、EPDS 分數配對）。平台設有遊戲化機制：完成每週任務可獲得「媽媽能量點數」，累積可兌換育兒電子書或冥想音檔。

****詳細步驟****：1. ****招募與篩選****：從台灣北、中、南三家醫學中心及衛生所，招募 400 位產後 1-2 週、年滿 20 歲、能讀寫中文、擁有智慧型手機的婦女（含初產婦與經產婦）。排除條件：嬰兒有重大先天疾病、母親有精神科診斷（如重度憂鬱症）或目前參與其他心理介入研究。2. ****隨機分派****：使用區塊隨機化（block randomization，區塊大小 4 或 6），按產次（初產/經產）和醫院分層，分配至介入組（n=200）和對照組（n=200）。3. ****介入內容設計****：- ****第 1 週：覺察與接納****（主題：產後的身心變化）- 影片：講解產後常見情緒波動與自我慈悲概念。- 意義練習：寫下「成為母親對我的意義」清單（至少 3 點）。- 自我慈悲練習：聆聽引導音檔進行 5 分鐘「自我慈悲暫停」（將手放在心上，對自己說「這很辛苦，沒關係」）。- 同儕討論：在社團中分享「這個週最令我感到壓力的時刻」。- ****第 2 週：連結與支持****（主題：尋求與給予支持）- 影片：探討社會支持的重要性與如何有效請求幫助。- 意義練習：反思「過去一週，誰給了我支持？我如何回饋？」。- 慈悲練習：進行「慈心冥想」（祝福自己、寶寶、家人）。- 討論：分享「我如何告訴家人我需要幫忙？」。- ****第 3 週：自我價值與內在力量****（主題：克服自我批評）- 影片：介紹自我慈悲的三要素（自我善待、共通人性、正念覺察）。- 意義練習：寫一封信給「感到挫敗的自己」，以朋友的口吻安慰。- 慈悲練習：「觸碰慈悲」冥想（將手放在心口，感受溫暖）。- 討論：分享「我常對自己說哪些苛刻的話？」。- ****第 4 週：適應與成長****（主題：從挑戰中看見成長）- 影片：介紹創傷後成長（PTG）概念，以及如何從育兒困難中找到意義。- 意義練習：完成「逆境中的領悟」工作表（如「這次挑戰教會了我什麼？」）。- 慈悲練習：「身體掃描」冥想，專注於身體感受並傳送慈悲。- 討論：分享「育兒過程中我變得更堅強的例子」。- ****第 5 週：連結未來****（主題：為母職角色注入希望）- 影片：探討如何將個人價值觀融入母職角色。- 意義練習：設定一個「微型目標」（如「本週每天擁抱寶寶 5 分鐘」）。- 慈悲練習：「慈悲呼吸」（吸氣時想著平靜，呼氣時送出愛）。- 討論：分享「我對寶寶未來的希望」。- ****第 6 週：整合與展望****（主題：持續練習與社群連結）- 影片：總結課程，鼓勵持續練習並維持同儕聯繫。- 意義練習：撰寫「母親宣言」（我的價值觀與承諾）。- 慈悲練習：引導式冥想「慈悲的河流」。- 討論：分享「課程結束後，我打算如何維持這些習慣？」。4. ****AI 配對機制****：後台演算法根據填寫的基礎問卷（產次、嬰兒是否早產、EPDS 分數、社會支持總分）計算相似度，將婦女分入 4-6 人小組，組內異質性低（如同為初產婦且 EPDS>10 者同一組），以增加共鳴。小組設有匿名討論區，並有護理師研究助理每週監看，確保無不當言論。5. ****對照組****：接受常規產後護理，包括醫院提供的產後衛教單張、門診追蹤，以及研究團隊提供的每月一次線上育兒知識電子報（不含心理介入內容）。6 個月後可獲得完整課程。

****質性研究****：從每組各隨機選取 20 位（共 40 位），於產後 6 個月進行半結構化深度訪談，探討意義建構、自我慈悲與同儕支持的經驗如何影響母職壓力。訪談大綱包括：「課程中哪個練習對你影響最大？」、「你如何運用自我慈悲來應對壓力？」、「同儕小組如何改變你的社會支持感受？」。

實驗計畫

****步驟 1：研究設計與倫理審查**** - 採用前瞻性、雙盲（評估者盲）、隨機對照試驗設計。 - 向三家醫學中心及衛生所的人體試驗委員會（IRB）申請審查，取得核准後始進行。

****步驟 2：樣本招募與分配**** - 目標樣本數：400 人（每組 200 人），根據 G*Power 計算，設定效應量 $f=0.25$ （中等）、 $\alpha=0.05$ 、統計力 0.85、重複測量 4 次、組間相關 0.5，需至少 200 人，考量 20% 流失率，招募 400 人。 - 招募管道：產後病房護理師於出院前 1 天介紹研究，由研究助理說明並取得書面同意。 - 隨機分派：使用中央隨機化系統（如 Sealed Envelope），由獨立統計人員產生隨機序號，護理師將參與者 ID 輸入系統後獲知分組。

****步驟 3：介入實施**** - 介入組於產後第 2 週開始 6 週課程，每週透過 App 推送通知，完成後解鎖下一週內容。參與者需在每週內完成所有練習（平台記錄完成度，建議以 80% 為遵從門檻）。 - 對照組收到常規衛教電子報，無介入課程。

****步驟 4：資料收集**** - 時間點：T0（出院時，基線）、T1（產後 1 個月）、T2（產後 3 個月）、T3（產後 6 個月）。 - 問卷工具： - 基本人口學變項（年齡、教育、收入、產次、分娩方式） - 母職壓力：使用「母職壓力量表」（Maternal Parenting Stress Scale, MPSS, Cronbach's $\alpha > 0.85$ ） - 憂鬱症狀：使用「愛丁堡產後憂鬱量表」（EPDS, 台灣版切截點 ≥ 10 ） - 社會支持：使用「社會支持量表」（SSS, 含家庭、朋友、專業支持次量表） - 母育信心：使用「母育信心量表」（Maternal Confidence Scale, MCS） - 母育能力：使用「母育能力量表」（Maternal Competence Scale） - 意義感：使用「生命意義量表」（Meaning in Life Questionnaire, MLQ, 存在意義與尋求意義次量表） - 自我慈悲：使用「自我慈悲量表短版」（Self-Compassion Scale-Short Form, SCS-SF） - 質性資料：於 T3 後，由受過訓練的訪談員進行錄音訪談，每次約 60 分鐘，全程轉謄為逐字稿。

****步驟 5：統計分析**** - 使用 SPSS 27.0 或 R 語言進行： - 描述性統計（平均數、標準差、頻率） - 組間基線比較（t 檢定、卡方檢定） - 主要分析：多層次模型（Hierarchical Linear Modeling, HLM），以時間（T0-T3）為層次 1，參與者為層次 2，組別（介入 vs. 對照）為固定因子，控制產次、醫院別、基線憂鬱分數。檢視組別 $\times$ 時間交互作用，若顯著則表示介入對趨勢有影響。 - 次群體分析：按產次（初產/經產）、社會支持高低、憂鬱風險（EPDS ≥ 10 vs. < 10 ）進行分組比較。 - 質性分析：使用主題分析法（Braun & Clarke, 2006），由兩位研究者獨立編碼，建立共識主題。

****步驟 6：成功指標**** - 主要結果：介入組在 T1-T3 的母職壓力分數顯著低於對照組（ $p < 0.05$ ），且下降斜率更陡。 - 次要結果：介入組的社會支持、母育信心、母育能力、意義感、自我慈悲分數顯著高於對照組；憂鬱分數顯著較低。 - 質性結果：浮現的主題包括「意義建構作為壓力緩衝」、「自我慈悲減少自我批評」、「同儕連結填補支持缺口」等。 - 若 HLM 分析顯示組別 $\times$ 時間交互作用顯著，且效應量 Cohen's $d \geq 0.3$ ，即視為臨床上有意義的成效。

****步驟 7：時間表與預算**** - 為期 24 個月：前 3 個月 IRB 申請與平台開發，第 4-9 個月招募，第 10-21 個月介入與追蹤，第 22-24 個月數據分析與論文撰寫。 - 預算：人事費（研究助理、訪談員）、平台維護費、問卷印製費、受試者車馬費（每人每次 NT\$500）、統計諮詢費、發表費。

可信新穎度 — 最接近的真實論文

- [The Effects of a Mobile Application Social Support Program on Postpartum Perceived Stress and Depression]. (66.8% · airiti.PubMed, 2016) — 增量：該論文僅探討行動應用程式社會支持方案對產後壓力與憂鬱的影響，未納入意義建構（如 logotherapy 練習）與自我慈悲訓練作為核心介入成分。本提案則整合意義感、自我慈悲與同儕支持三元素，並以母職角色達成（Maternal Role Attainment）為主要結果變項，而非僅聚焦於壓力與憂鬱。此外，本提案採用隨機對照試驗設計，並包含遊戲化機制與 AI 配對同儕小組，方法上更為複雜且多層次。（相似度 67% 偏高，標籤經相似度守衛下修）
- Intervention Effect of Micro-class Education Combined with Midwives Psychological Nursing on Postpartum Depression Patients (66.1% · airiti.AL, 2022) — 增量：該論文聚焦於微課教育合併心理護理對產後憂鬱患者的介入，對象為已確診產後憂鬱症的患者，且介入方式為面對面

或傳統教育形式。本提案則針對一般產後婦女（非臨床樣本），以預防性角度設計線上方案，並強調意義感與自我慈悲的內在資源培養，而非僅以理性情緒療法為基礎。此外，本提案包含同儕支持與遊戲化機制，方法上為隨機對照試驗，與該論文的研究設計不同。（相似度 66% 偏高，標籤經相似度守衛下修）

- [The Effectiveness of an Early Parental Sensitivity Intervention on Attachment, Parenting Confidence, and Parental Stress in Mothers of Preterm Infants]. (65.8% · airtiti.PubMed, 2025) — 增量: 該論文針對早產兒母親進行早期親職敏感性介入，對象為早產兒母親，且介入重點為依附關係與親職信心。本提案則聚焦於一般產後婦女（含足月產），並以意義感、自我慈悲與同儕支持為核心，目標為母職角色達成與心理健康，而非僅針對親職敏感性。此外，本提案採用線上平台與 AI 配對機制，與該論文的面對面或醫院為基礎的介入方式有別。（相似度 66% 偏高，標籤經相似度守衛下修）

參考文獻

1. Discharge planning, social support, postpartum depression, and maternal confidence: A correlation study among mothers of preterm infants
2. Relationships between Social Supports, Maternal Confidence, Maternal Competence, and Maternal Parenting Stress in the Postpartum Period of Postpartum Women : Multilevel Analysis
3. A Compare of The Postpartum Depression Related Factors in Early Postpartum Women With or Without Depression.
4. Risk and protective factors for pre- and postnatal bonding.
5. Maternal Confidence at Infant Discharge: Comparing Preterm and Fullterm Groups
6. Promotion of parental roles and improvement of mental health using an online program: A randomized controlled trial
7. The Effect of Bergamot Essential Oil Aromatherapy on Improving Depressive Mood and Sleep Quality in Postpartum Women: A Randomized Controlled Trial
8. Comparing maternal confidence and social supports between younger and elder primiparas in the early postpartum period
9. Experiences of feeling positive emotions in online parenting forums among 2-3 months postpartum mothers
10. Online Peer Support and Well-being of Mothers and Children: Systematic Scoping Review
11. Comfort with Motherhood in Late Pregnancy Facilitates Maternal Role Attainment in Early Postpartum
12. 產後不同時段婦女之心理社會狀況
13. Clustering Analysis of Onomatopoeia Co-occurrence Words in Search Queries on Mother-targeted Websites
14. 初產婦與經產婦之心理社會影響
15. Exploring the Relationship of Social Support and Postpartum Stress amongst Postpartum women in the Solomon Islands

16. The Relationship between Maternal Depressive Symptoms and Mother-Preterm Infant Interactions during Early Postpartum Period in Indonesia

Postpartum Depression .

17. The Effectiveness of Internet Social Networking Site on Pregnancy Women's Psycho-Physical Symptoms, depression, Social Support, Maternal Fetal Attachment and Pregnancy Adaptation
18. Information Gaps and Institutional Challenges in Taiwan's Maternal Care System: A Perspective from Pregnant Women
19. Sleep Quality of Postpartum Women: A Triangulation Study
20. The Effects of Life Stress and Peer Support on Youth's Internalizing and Externalizing Problems: Examining the Differences between Offline and Online Peer Support
21. Repeated Measures for Hyperglycemia Women's Social Support, Stress, and Depression during the Perinatal Period
22. Relationships Between Postpartum Stress, Social Support, and Depression, and Health Status of the Premature Infant's Mother.
23. Stress-Buffering Role of Social Support during COVID-19.
24. Proposals for improving maternal safety (2023 edition): Insights from the analysis of maternal deaths in Japan.
25. ESSENTIAL STEPS FOR LATENT GROWTH CURVE MODELING IN TAIWANESE PANEL STUDY
26. Depression in Middle Aged and Older Adults: A Multilevel Method Study
27. Systematic review of the literature on postpartum care: effectiveness of interventions for smoking relapse prevention, cessation, and reduction in postpartum women.
28. 懷孕婦女三孕期之噁心嘔吐、疲憊、壓力知覺及社會支持的縱貫性研究
29. Postpartum Women's Social Support, Depression, and Health-related Quality of Life: A Repeated-Measure Study Design
30. Happiness and its Related Factors among Postpartum Women with Breastfeeding
31. 影響臺灣青年職涯發展之社會網絡分析
32. Actual Social Support, Virtual Social Support, Self-esteem and Internet Addiction among Senior High School Students in Taiwan

Developmental Delay .

of Preterm Infants .

33. FACTORS AFFECTING THE STRESS RESPONSES OF MOTHERS WHO CARE FOR A PERSON WITH SEVERE MENTAL RETARDATION AT HOME : CAUSAL ANALYSIS USING STRUCTURAL EQUATION MODELING

34. Further psychometric testing and use of the Maternal Confidence Questionnaire
35. Sources of maternal confidence and uncertainty and perceptions of problem-solving competence
36. Maternal confidence, knowledge, and quality of mother – toddler interactions: a preliminary study
37. Maternal confidence in toddlerhood: Its measurement for clinical practice and research
38. Maternal confidence during toddlerhood: Comparing pre-term and full-term groups
39. Comparison of confidence between mothers who breastfed and formula fed their preterm infants
40. The determinants of parenting behavior
41. The determinants of parenting: A process model
42. Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change
43. Self-Efficacy-The Exercise of Control
44. Social support as a moderator of life stress
45. Correlates of first-time mothers' postpartum stress
46. Variables related to motherhood in normal primiparous woman
47. Psychosocial features at different periods after childbirth
48. The psychosocial consequences for primiparas and multiparas

產後母職壓力異質性軌跡對幼兒執行功能的影響：母育信心與社會支持的調節角色—基於 KIT 資料庫的潛在類別分析

後設資料

想法編號: seed-theory-1=>2=>2=>1

新穎度: 36.4%

最大相似度: 63.6% (近似於: “Factors related to the mental health of postpartum mothers : focusing on the relationship between child-rearing stress and self-efficacy”)

群集: 4

競賽得分: 3 勝

方法論契合度: 2/5

Methodology Reasoning: Uses longitudinal data but applies latent class analysis and focuses on child executive function at 36 months, which diverges from the target’s multilevel analysis of early postpartum trajectories.

問題陳述

產後母職壓力是影響母嬰健康的重要因子，然而，過去研究多將母職壓力視為一個同質性構念，或僅探討其平均變化趨勢（如線性下降），忽略了母親之間可能存在截然不同的壓力軌跡類型。例如，有些母親可能經歷「持續高壓力」、有些「先升後降」、有些「低壓力穩定」。這些異質性軌跡可能對幼兒的認知發展，特別是執行功能（如抑制控制、工作記憶、認知彈性），產生不同的長期影響。執行功能是學齡前兒童學校準備度與未來學業成就的關鍵預測因子，且大腦前額葉皮層在產後前三年呈現快速發展，對環境壓力極為敏感。目前，雖然有少量研究探討產後憂鬱軌跡與幼兒執行功能的關係（如參考文獻中的 Maternal Depressive Mood Trajectory...），但針對「母職壓力」此一更具體、與日常育兒互動直接相關的構念，其異質性軌跡對執行功能的影響仍未被充分探索。此外，保護因子如「母育信心」與「社會支持」如何緩衝不同壓力軌跡對幼兒發展的負面效應，機制仍不明確。本研究旨在填補此缺口，利用臺灣大型縱貫資料庫（KIT，N=5,458），運用潛在類別分析（LCA）識別產後 3 至 36 個月的母職壓力異質性軌跡，並檢驗母育信心與社會支持是否調節軌跡與幼兒 36 個月時執行功能之間的關聯。研究結果將有助於早期篩查出高風險壓力軌跡的母親，並提供個人化介入的實證基礎，例如針對「持續高壓力」群體加強社會支持網絡，或針對「壓力增加」群體提升母育信心，從而促進幼兒健康發展。

現有方法

目前探討產後壓力與幼兒發展關係的研究，多採用以下方法：1. ****橫斷面相關研究****：如 A Study on the Association... 與 Preschool Executive Control... 等研究，通常在同一時間點測量母職壓力與幼兒執行功能，使用迴歸分析或相關分析。此類方法無法捕捉壓力的動態變化，且因果推論受限。2. ****平均軌跡分析****：如目標論文（產後婦女... 母職壓力之關係：多層次分析）使用多層次模型（HLM）探討壓力的平均變化趨勢，並分析社會支持、母育信心等變項的影響。然而，HLM 假設所有個體遵循相同的平均變化模式，忽略個體間的異質性，無法區分出不同的壓力軌跡亞群。3. ****憂鬱軌跡研究****：如 Maternal Depressive Mood Trajectory... 與 Heterogeneity of postpartum depression... 等研究，對產後憂鬱進行 LCA 或成長混合模型（GMM），但憂鬱與母職壓力是不同構念（壓力更直接與育兒任務相關），且這些研究較少延伸至幼兒執行功能結果。4. ****中介或調節模型****：如 The relationship between parenting self-efficacy... 探討母育效能透過憂鬱影響幼兒行為問題，但未區分壓力軌跡的異質性，且樣本量較小（數百人）。

****限制歸納****：- 缺乏對母職壓力異質性軌跡的系統性探索。- 現有縱貫研究多聚焦於憂鬱而非壓力，且樣本量不足（如目標論文 N=305），難以進行 LCA。- 未同時考量母育信心與社會支持作為調節變項，對不同壓力軌跡與執行功能關係的緩衝效果。- 幼兒執行功能的測量多依賴母親報告，缺乏客觀指標，且未利用大型全國代表性資料庫。

研究動機

現有研究方法不足以解決本問題的原因在於：首先，母職壓力本質上是異質性的，有些母親可能因嬰兒氣質、自身資源或環境因素而呈現不同的壓力變化模式。使用平均軌跡（如 HLM）會掩蓋這些差異，導致無法精準識別高風險群體。LCA 能夠根據壓力變化模式將母親分為數個潛在類別（如「高壓力穩定」、「壓力增加」、「低壓力下降」等），從而提供更細緻的介入標靶。其次，現有研究較少探討壓力軌跡對幼兒執行功能的具體影響，而執行功能是神經發展的重要指標。根據生物生態學理論，母親壓力會透過影響親子互動品質、家庭混亂程度及 HPA 軸功能，進而影響幼兒大腦發育。因此，區分不同壓力軌跡對執行功能的差異效應至關重要。再者，母育信心和社會支持是已知的保護因子，但對於不同壓力軌跡的母親，其保護效果可能不同。例如，對於「壓力增加」的母親，即時提升母育信心可能特別有效；而對於「持續高壓力」的母親，可能需要更強的社會支持介入。現有研究未針對不同軌跡類型檢驗這些調節效應。最後，KIT 資料庫（N=5,458）提供了足夠的統計檢定力進行 LCA，且包含多次追蹤（3、6、12、24、36 個月）的母職壓力測量，以及 36 個月時的直接評量（如執行功能任務），克服了過去研究樣本小、測量主觀的限制。本提案的靈感來自於將 LCA 應用於產後憂鬱的成功經驗（如 Heterogeneity of postpartum depression），但進一步擴展至母職壓力，並結合調節效應分析。我們假設，相較於平均軌跡方法，LCA 能更準確預測幼兒執行功能結果，且母育信心與社會支持對不同軌跡類別具有不同的緩衝作用。此方法將提供個人化預防策略的科學依據。

提出方法

方法總覽本研究採用次級資料分析，使用 KIT 資料庫（「臺灣幼兒發展調查資料庫建置計畫」36 月齡組，N=5,458）。首先，利用潛在類別分析（LCA）基於產後 3、6、12、24、36 個月五個時間點的母職壓力分數，識別出異質性的壓力軌跡類別。其次，以幼兒 36 個月時的執行功能（包括抑制控制、工作記憶、認知彈性）為結果變項，使用包含類別成員身份、母育信心、社會支持及其交互作用的多元迴歸或結構方程模型，檢驗調節效應。

詳細步驟

步驟一：變項操作型定義與資料準備- ****母職壓力****：使用 KIT 問卷中的「母職壓力」分量表（如改編自 Parenting Stress Index），測量時間點為 3、6、12、24、36 個月。分數越高表示壓力越大。- ****母育信心****：使用 KIT 中的「母育信心」量表（如改編自 Maternal Confidence Questionnaire），測量時間點為 6、12、24 個月（取平均值或使用最近一次測量）。- ****社會支持****：使用 KIT 中的「社會支持」量表（如改編自社會支持問卷），測量時間點同母育信心。- ****幼兒執行功能****：使用 KIT 在 36 個月時直接評量的執行功能任務，包括：(a) 抑制控制：如「紅花/白花」任務；(b) 工作記憶：如「尋找貼紙」任務；(c) 認知彈性：如「分類轉換」任務。可將三個任務分數標準化後取平均作為綜合指標。- ****共變項****：母親年齡、教育程度、家庭收入、嬰兒性別、出生體重、氣質（如困難氣質）。

步驟二：潛在類別分析（LCA）- 使用 Mplus 或 R 套件（如 lcmm）進行 LCA，以五個時間點的母職壓力分數為指標。- 測試 1 至 6 個類別的模型，根據以下指標選擇最佳模型：(a) 貝氏訊息準則（BIC）越低越好；(b) 熵（Entropy）接近 1 表示分類準確；(c) 類別大小至少 5% 樣本；(d) Lo-Mendell-Rubin 調整概似比檢定（LMR-LRT）顯著表示增加類別顯著改善模型。- 預期可能出現的類別包括：「低穩定」（約 40%）、「中度下降」（約 30%）、「高壓力增加」（約 15%）、「高壓力下降」（約 10%）、「持續高壓力」（約 5%）。

步驟三：調節效應分析- 將每個個體歸入最可能的類別（基於後驗機率），作為類別變項。- 使用線性迴歸或結構方程模型（SEM），以幼兒執行功能為依變項，預測變項包括：(a) 壓力軌跡類別（虛擬編碼）；(b) 母育信心（連續變項）；(c) 社會支持（連續變項）；(d) 交互作用項：類別 × 母育信

心、類別 × 社會支持、類別 × 母育信心 × 社會支持（三階交互作用）。- 控制上述共變項。- 若交互作用顯著，進行簡單斜率分析或 Johnson-Neyman 技術，以識別在不同信心/支持水平下，壓力軌跡對執行功能的條件效應。

步驟四：穩健性檢驗- 使用多重插補處理遺漏值（KIT 資料庫遺漏率可能低於 20%）。- 採用直接包含分類誤差的方法（如 Mplus 中的三步驟法或 BCH 法）來校正 LCA 分類不確定性對後續分析的影響。- 將執行功能分為三個面向分別分析，以檢驗是否特定面向更敏感。

實驗計畫

實驗步驟計劃

步驟 1：資料取得與倫理審查- 向 KIT 資料庫管理單位（臺灣學術調查資料庫，SRDA）申請使用 36 月齡組完整資料（已通過 IRB）。- 取得資料後，確認變項名稱、編碼及缺失值模式。

步驟 2：樣本篩選與描述性統計- 納入條件：至少完成 3、6、12、24、36 個月五個時間點中三個時間點的母職壓力測量（以確保軌跡估計穩定）。- 描述樣本特徵（ $M \pm SD$ 或 $n\%$ ），並比較納入與排除樣本。

步驟 3：執行 LCA 模型建構- 使用 R 套件 'lcm' 或 'tidyLPA' 進行 LCA。- 設定種子值（seed=12345）以確保可重複性。- 比較 2 至 6 類模型，記錄 BIC、AIC、Entropy、LMR-LRT p 值。- 選擇最適模型後，視覺化各類別的壓力平均軌跡。

步驟 4：主分析—調節效應- 使用 R 的 'lavaan' 或 Mplus 進行 SEM。- 模型設定：- 執行功能 = $\beta_0 + \beta_1(\text{類別 dummy1}) + \beta_2(\text{類別 dummy2}) + \dots + \beta_k(\text{母育信心}) + \beta_l(\text{社會支持}) + \beta_m(\text{類別} \times \text{信心}) + \beta_n(\text{類別} \times \text{支持}) + \beta_o(\text{類別} \times \text{信心} \times \text{支持}) + \gamma^*(\text{共變項}) + \varepsilon$ - 使用穩健標準誤（MLR 估計器）。- 結果預期：若「高壓力增加」類別與「低穩定」類別相比，對執行功能有顯著負向效應（ β 為負），且母育信心與社會支持顯著緩衝此效應（交互作用項 β 為正）。

步驟 5：穩健性分析- 方法一：使用 BCH 三步驟法重新分析。- 方法二：將執行功能分為抑制控制、工作記憶、認知彈性三個依變項分別分析。- 方法三：加入額外共變項如母親憂鬱（以確認壓力軌跡的獨特貢獻）。

步驟 6：結果解讀與比較- 與現有文獻比較：如與 Maternal Depressive Mood Trajectory 研究對比，討論壓力與憂鬱軌跡的異同。- 計算效應量（Cohen's f^2 ）以評估實質顯著性。

評量成功的指標- LCA 模型 BIC 最低、Entropy > 0.80，且類別具臨床意義（如存在「持續高壓力」群）。- 主要假設成立：至少一個壓力軌跡類別（如「高壓力增加」）顯著預測較差的執行功能。- 調節效應顯著：母育信心與社會支持對高風險類別具有顯著緩衝效果（交互作用 $p < 0.05$ ）。- 結果發表於 Journal of Nursing Research 或 Infant Mental Health Journal 等期刊。

可信新穎度 — 最接近的真實論文

- Factors related to the mental health of postpartum mothers : focusing on the relationship between child-rearing stress and self-efficacy (63.6% · airiti.AL, 2015) — 區隔明確：該論文僅探討育兒壓力與自我效能對產後心理健康的橫斷面關聯，未使用縱貫資料追蹤壓力軌跡，也未將幼兒執行功能作為結果變項，更未採用潛在類別分析識別異質性軌跡或檢驗調節效應。本研究則聚焦於母職壓力異質性軌跡對幼兒執行功能的長期影響，並納入母育信心與社會支持的調節角色，方法上採用潛在類別分析與結構方程模型，與該論文有本質差異。
- Heterogeneity of postpartum depression: a latent class analysis. (62.9% · airiti.PubMed, 2015) — 區隔明確：該論文使用潛在類別分析探討產後憂鬱症狀的異質性亞型，但結果變項為憂鬱症狀本身，而非母職壓力軌跡對幼兒執行功能的影響，也未納入母育信心與社會支持作為調節變項。本研究雖同樣運用潛在類別分析，但聚焦於母職壓力（非憂鬱）軌跡，且以幼兒認知發展為結果，並檢驗保護因子的調節效應，研究問題與分析架構有顯著不同。

- Like mother, like child? Maternal determinants of children's early social-emotional development. (62.3% · airtiti.PubMed, 2019) — 區隔明確: 該論文探討母親因素(如憂鬱、教養行為)對幼兒社會情緒發展的縱貫影響,但未使用潛在類別分析識別母職壓力軌跡,也未將執行功能(抑制控制、工作記憶、認知彈性)作為特定結果變項,更未檢驗母育信心與社會支持的調節角色。本研究則以母職壓力異質性軌跡為核心預測變項,並聚焦於執行功能,方法與角度均不同。

參考文獻

1. Disease Prediction and Variable Selection by Using Particle Swarm Optimization and Classifier
2. Intervention Effect of Micro-class Education Combined with Midwives Psychological Nursing on Postpartum Depression Patients
3. A Study on the Association between Young Children's Sleep Status and their Executive Function
4. Preschool Executive Control, Temperament, and Adolescent Dietary Behaviors.
5. Factors related to the mental health of postpartum mothers : focusing on the relationship between child-rearing stress and self-efficacy
6. The relationship between parenting self-efficacy and toddler behavior problems: maternal depression as a mediator
7. Proposals for improving maternal safety (2023 edition): Insights from the analysis of maternal deaths in Japan.
8. Maternal morbidity and mortality: an iceberg phenomenon.
9. Relationships Among Marital Adjustment, Communication Patterns, Social Support, and Paternal Postpartum Depression
10. Relationship between self-evaluation of child birth experience and early postpartum depression
11. Discharge planning, social support, postpartum depression, and maternal confidence: A correlation study among mothers of preterm infants
12. A Compare of The Postpartum Depression Related Factors in Early Postpartum Women With or Without Depression.
13. Relationships between Social Supports, Maternal Confidence, Maternal Competence, and Maternal Parenting Stress in the Postpartum Period of Postpartum Women : Multilevel Analysis
14. Maternal Depressive Mood Trajectory and the Development of Executive Function in Three-Year-Old Children
15. Heterogeneity of postpartum depression: a latent class analysis.
16. Systematic review of the literature on postpartum care: effectiveness of interventions for smoking relapse prevention, cessation, and reduction in postpartum women.
17. The Reliability, Validity and Measurement Equivalence of the Social Behavior Assessment System for Preschool-Parent Rating Scale

18. Maternal Confidence at Infant Discharge: Comparing Preterm and Fullterm Groups

Postpartum Women .

en After a Stillbirth .

19. Comfort with Motherhood in Late Pregnancy Facilitates Maternal Role Attainment in Early Postpartum
20. Compare Stress and Social Support between Adolescent and Adult Pregnant Women during Third Trimester
21. Maternal stress, parenting factors, experiences in day care, and developmental outcomes in 5-year-old children in day care in Japan(Paper & Abstract September 18th)
22. Support from Advisors on Child Rearing for Alleviating Maternal Anxiety and Depressive Symptoms among Japanese Women
23. Social and household factors affecting child health checkup attendance based on a household survey in Japan
24. 'It is a hard decision': a qualitative study of perinatal intimate partner violence disclosure.
25. Comparing maternal confidence and social supports between younger and elder primiparas in the early postpartum period
26. Risk and protective factors for pre- and postnatal bonding.
27. Longitudinal Effects of Body Mass Index and Self-Esteem on Adjustment From Early to Late Adolescence: A Latent Growth Model
28. Exploring the Relationship Between Parent-Child Shared Book Reading and Executive Function at 2 Years: Language as a Mediator
29. The Impact of Developmental Screening on the Parents' Cognition of Child Development, and Attitude and Behavior in Seeking Medical Care
30. Exploring the Relationship of Social Support and Postpartum Stress amongst Postpartum women in the Solomon Islands
31. Impact, self-coping, and social support of patients with Spinocerebellar Ataxia
32. Prevalence and risk factors for postpartum depression 2 months after a vaginal delivery: a prospective multicenter study.
33. The Influence of Confinement Location on Maternal Psychological and Role Adaptation: A Six-Month Follow-Up Study
34. An Innovative Business Model that Combines Postpartum Maternal Health Care and Medical Tourism — The International Maternal and Child Health Care Village Planning
35. A Study of Relationship between Life Stress, Coping Style, Social Support and Emotion of Adjustment of Single Parents in Kaohsiung County
36. Further psychometric testing and use of the Maternal Confidence Questionnaire

37. Sources of maternal confidence and uncertainty and perceptions of problem-solving competence
38. Maternal confidence, knowledge, and quality of mother – toddler interactions: a preliminary study
39. Maternal confidence in toddlerhood: Its measurement for clinical practice and research
40. Maternal confidence during toddlerhood: Comparing pre-term and full-term groups
41. Comparison of confidence between mothers who breastfed and formula fed their preterm infants
42. The determinants of parenting behavior
43. The determinants of parenting: A process model
44. Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change
45. Self-Efficacy-The Exercise of Control
46. Social support as a moderator of life stress
47. Correlates of first-time mothers' postpartum stress
48. Variables related to motherhood in normal primiparous woman
49. Psychosocial features at different periods after childbirth
50. The psychosocial consequences for primiparas and multiparas

產前親子連結的日常波動與母職適應軌跡：一項整合經驗取樣與生理指標的混合方法縱貫研究

後設資料

想法編號: seed-domain-1=>3=>2=>1

新穎度: 19.7%

最大相似度: 80.3% (近似於: “Risk and protective factors for pre- and postnatal bonding.”)

群集: 8

競賽得分: 3 勝

方法論契合度: 5/5

Methodology Reasoning: Prospective longitudinal design with repeated postpartum measures, uses target paper’s scales for social support, maternal confidence, competence, and parenting stress, and employs multilevel growth curve models, directly extending the target methodology.

問題陳述

母育信心與母職壓力是影響產後婦女心理健康及嬰兒發展的關鍵因素。目標論文已指出，產後社會支持、母育信心與能力隨時間變化，且與壓力呈負相關。然而，現有研究多聚焦產後階段，忽略了產前心理因素（如親子連結、舒適感）對產後適應軌跡的長期影響。產前親子連結被認為是母職角色認同的基礎，但其對產後信心與壓力的預測力尚未被縱貫性驗證。此外，傳統問卷測量僅捕捉產前單一時間點的靜態感受，無法反映親子連結在日常中的動態波動。例如，孕婦可能因胎動或壓力事件而經歷連結感的瞬間變化，這些微觀經驗可能比單次總分更能預測產後適應。同時，缺乏對伴侶支持如何經由產前連結影響產後結果的機制探討。本研究旨在填補此缺口，透過整合經驗取樣法 (Experience Sampling Method, ESM) 與心率變異性 (HRV) 生理指標，捕捉產前親子連結的日常波動，並檢視其對產後母育信心與母職壓力軌跡的預測力。此問題的重要性在於：(1) 推動產前評估從靜態轉向動態，提升預測精準度；(2) 開創結合生理與心理指標的母職適應模型；(3) 為產前介入（如連結增進方案）提供實證基礎，以降低產後壓力風險。

現有方法

現有方法主要依賴橫斷面或縱貫性問卷調查，如目標論文使用多層次分析追蹤產後社會支持、信心與壓力。其他研究如「Concept Analysis of Maternal Confidence」與「Comfort with Motherhood in Late Pregnancy」雖探討產前舒適感，但均以單次問卷測量。常見工具包括愛丁堡產後憂鬱量表 (EPDS)、產前親子連結量表 (PBQ) 及母育信心量表。局限性包括：(1) 忽略產前心理變項的日常變異性，僅假設其為穩定特質；(2) 缺乏客觀生理指標，完全依賴自我報告，易受回憶偏誤影響；(3) 伴侶支持與產前連結的交互作用未被充分模型化；(4) 多數研究使用傳統迴歸，無法同時分析個體內與個體間變化。這些方法無法捕捉產前經驗的即時動態，導致預測模型解釋力有限。

研究動機

現有方法不足以解決問題，因為它們將產前連結視為靜態變項，忽視了日常波動對產後適應的獨特貢獻。我的靈感來自於情感動態學 (affective dynamics) 與生態瞬時評估 (ecological momentary assessment, EMA) 在心理健康領域的成功應用。例如，產前連結的日常波動（如高變異性可能反映情緒不穩定）可能比平均分數更能預測產後壓力。此外，HRV 作為自主神經系統的指標，可客觀反映壓力調節能力，與母職壓力相關。因此，本研究提出創新方法：結合經驗取樣法（每日隨機提示記錄連結感）與 HRV 監

測，並使用多層次結構方程模型 (MSEM) 分析波動模式如何調節產後軌跡。此方法能：(1) 提供更細緻的產前預測指標；(2) 減少回憶偏誤；(3) 揭示伴侶支持透過連結波動間接影響產後結果的機制。相較於傳統方法，動態測量更能反映真實母職準備過程，預期能顯著提升預測模型的解釋力。

提出方法

本方法提出一個混合方法縱貫研究設計，整合量化與質性資料，分為三個階段。

****第一階段：產前動態測量（懷孕 32-36 週）**** - 招募 400 名初產婦與經產婦（比例 1:1），排除高風險妊娠。- 使用經驗取樣法 (ESM)：參與者配戴穿戴裝置（如 Fitbit Charge 5）連續 7 天，每天隨機收到 5 次提示（通過手機 App），每次完成簡短問卷（約 1 分鐘），測量當下親子連結感（1-7 分）、舒適感、壓力與伴侶互動。同時記錄 HRV（RMSSD 指數）。- 每日睡前填寫日記，記錄當日有意義的親子互動事件（如胎動感受）。- 於第 1 天與第 7 天完成完整問卷：產前親子連結量表 (PBQ)、產前舒適量表、EPDS、伴侶支持量表。

****第二階段：產後縱貫追蹤（產後 1 週、1 月、4 月、6 月）**** - 每次追蹤點收集：社會支持量表、母育信心量表、母育能力量表、母職壓力量表（與目標論文一致）。- 同時進行 15 分鐘半結構質性訪談（僅在產後 1 月與 6 月），探討母職角色轉變經驗（如「什麼時候你覺得自己像個母親？」）。- 持續穿戴裝置至產後 1 月，記錄 HRV 與睡眠品質作為客觀壓力指標。

****第三階段：數據分析與整合**** - ****量化分析****：使用多層次成長曲線模型 (MLM) 分析產後信心與壓力軌跡，並將產前 ESM 衍生指標（如連結波動度、HRV 變異性）作為時間不變預測因子。使用多層次結構方程模型 (MSEM) 測試中介路徑：伴侶支持→產前連結波動→產後信心/壓力。- ****質性分析****：對訪談文本進行主題分析，識別母職適應的關鍵轉折點，並量化編碼為類別變項納入模型。- ****混合整合****：採用 Joint Display 方法，將量化軌跡模式與質性主題對應，例如高連結波動組常伴隨「角色衝突」主題。

****獨特創新點****：- 首次將 ESM 應用於產前連結研究，捕捉日常微觀動力。- 整合 HRV 作為客觀壓力生理指標。- 混合方法設計提供深層機制解釋。- 動態預測因子可提升早期篩檢準確性。

實驗計畫

****步驟一：研究設計與倫理審查**** - 提交 IRB 申請（預計 3 個月），確保所有參與者簽署知情同意。- 設計 ESM 手機 App（使用 Expiwell 或 mPath 平台），包含隨機提示與日記功能。- 採購 Fitbit Charge 5 裝置（每台約 \$150 美元）共 50 台，輪流使用。

****步驟二：樣本招募與資料收集**** - 於台灣北部與中部各一家醫學中心產科門診進行招募，目標 400 人。納入條件：20-40 歲、單胎、無妊娠併發症。排除條件：精神病史、早產風險。- 產前階段（32 週）：完成首次問卷（PBQ、EPDS 等），配戴裝置 7 天。ESM 提示頻率每天 5 次（隨機間隔 2-4 小時）。- 產後階段：於出院前、1 月、4 月、6 月門診或居家訪視時收集問卷。質性訪談於 1 月與 6 月進行（每次 20 分鐘，錄音轉錄）。

****步驟三：數據處理與變項建構**** - 計算 ESM 指標：親子連結平均分、波動度（個體內標準差）、HRV 日平均與變異係數。- 問卷數據：社會支持 (SSQ)、母育信心 (MCS)、母育能力 (MCCS)、母職壓力 (PSS) 按原量表計分。- 缺失數據處理：使用多重插補 (MI) 處理遺漏值。

****步驟四：統計分析**** - 使用 SPSS 26.0 與 Mplus 8.0。- 先進行描述性統計與相關分析。- 建立多層次成長曲線模型 (MLM)：層次 1 為時間（4 個時間點），層次 2 為個體。預測因子包括產前連結波動、HRV 變異性、伴侶支持。控制變項：產次、教育程度、年齡。- MSEM 中介模型：檢驗伴侶支持→產前連結波動→產後壓力路徑。- 質性主題分析使用 NVivo 12，由兩位研究者獨立編碼，信度 Kappa > 0.8。

****步驟五：結果評估**** - 主要結果：產後母育信心與母職壓力軌跡的斜率與截距。- 成功指標：產前連結波動度顯著預測產後壓力上升斜率 ($\beta > 0.2, p < 0.05$)；HRV 變異性顯著負向預測信心軌跡 ($\beta < -0.15, p < 0.05$)。質性主題與量化模式一致（如高波動組報告「角色不確定性」）。

****步驟六：預期產出**** - 發表於《護理雜誌》或《Journal of Advanced Nursing》。- 開發「產前動態風險評估工具」，用於早期識別高壓力風險產婦。- 提供產前介入方案（如即時回饋 ESM App）的理

論基礎。

可信新穎度 — 最接近的真實論文

- Risk and protective factors for pre- and postnatal bonding. (80.3% · airtiti.PubMed, 2019) — 高度重疊: 該論文探討產前與產後親子連結的風險與保護因子, 但僅使用傳統問卷在單一時間點測量, 未捕捉日常波動。本提案採用經驗取樣法 (ESM) 連續 7 天測量產前親子連結的瞬間變化, 並整合心率變異性 (HRV) 作為生理指標, 且進一步追蹤產後母育信心與壓力軌跡, 而非僅聚焦於連結本身。(相似度 80% 偏高, 標籤經相似度守衛下修)
- Comfort with Motherhood in Late Pregnancy Facilitates Maternal Role Attainment in Early Postpartum (73.8% · airtiti.AL, 2015) — 增量: 該論文探討產前舒適感對產後母職角色達成的影響, 但僅在單一時間點 (懷孕晚期) 測量舒適感, 且未納入動態波動或生理指標。本提案不僅測量產前親子連結的日常波動 (透過 ESM), 還整合 HRV 作為客觀壓力指標, 並縱貫追蹤產後母育信心與壓力軌跡, 而非僅聚焦於角色達成。
- Factors related to the mental health of postpartum mothers : focusing on the relationship between child-rearing stress and self-efficacy (70.8% · airtiti.AL, 2015) — 增量: 該論文探討產後育兒壓力與自我效能對產後心理健康的影響, 但僅在產後單一時間點進行橫斷面分析, 且未納入產前因素。本提案從產前開始追蹤, 捕捉親子連結的日常波動 (ESM) 與生理指標 (HRV), 並縱貫分析產後信心與壓力軌跡, 同時探討伴侶支持的中介機制。

參考文獻

1. Relationships between Social Supports, Maternal Confidence, Maternal Competence, and Maternal Parenting Stress in the Postpartum Period of Postpartum Women : Multilevel Analysis
2. The Influence of Confinement Location on Maternal Psychological and Role Adaptation: A Six-Month Follow-Up Study
3. Concept Analysis of Maternal Confidence
4. Risk and protective factors for pre- and postnatal bonding.
5. Comfort with Motherhood in Late Pregnancy Facilitates Maternal Role Attainment in Early Postpartum
6. Discharge planning, social support, postpartum depression, and maternal confidence: A correlation study among mothers of preterm infants
7. A longitudinal study of paternal mental health problems from the antenatal to the postpartum period: riskfactors, relationship with maternal factors and impact of gender roleand traditionalism-modernity
8. Postrartum Adjustment of Women who were Home During the "Traditional Chinese one Month Postrartum Period of Confinement" and Those who were in Maternity Care Centers
9. A STUDY ON THE MEDICAL AND WELFARE ENVIRONMENT IN POSTPARTUM CARE (PART 1): THE SYSTEM AND ACTUAL CONDITION OF POSTPARTUM CARE CENTERS IN TAIWAN
10. The Relationship Between Maternal Parenting Stress and Breastfeeding Experience of Postpartum Women

11. The Relationships between Family Structure, Postpartum Care and Depression in Postpartum
12. 初產婦與經產婦之心理社會影響
13. THE DEVELOPMENT OF INFANT TEMPERAMENT AND ITS RELATIONSHIP WITH MATERNAL TEMPERAMENT
14. Effect of maternal fearfulness, prenatal anxiety and postpartum depression on 4-month-old infant temperament in Chinese populations: a follow-up study
15. Contribution of Parenting Factors to the Developmental Attainment of 9-Month-Old Infants: Results From the Japan Children's Study
16. 嬰兒氣質、母乳哺餵經驗與產後憂鬱之相關探討
17. Factors related to the mental health of postpartum mothers : focusing on the relationship between child-rearing stress and self-efficacy
18. A Compare of The Postpartum Depression Related Factors in Early Postpartum Women With or Without Depression.
19. The business strategy of postpartum caring center
20. A Study on the Correlation between the mother-infant bonding and postpartum depression
21. A longitudinal study of maternal anxiety from the antenatal to the postpartum period: risk factors and adverse outcomes on infant temperament and development
22. Paternal depression and anxiety: risk factors and adverse impact on infant temperament and development
23. Maternal Confidence at Infant Discharge: Comparing Preterm and Fullterm Groups
24. Methods for Analyzing Longitudinal Data in Developmental Research: Growth Curve Model and Latent Class Growth Analysis
25. Heterogeneity of postpartum depression: a latent class analysis.
26. An Exploratory Study of the Postpartum Stress and its Related Factors
27. Factors Related to Health-Promoting Lifestyle Behaviors among Postpartum Women during their Doing the Month Period
28. Review of Postpartum Care Studies 1970-2004
29. Further psychometric testing and use of the Maternal Confidence Questionnaire
30. Sources of maternal confidence and uncertainty and perceptions of problem-solving competence
31. Maternal confidence, knowledge, and quality of mother – toddler interactions: a preliminary study
32. Maternal confidence in toddlerhood: Its measurement for clinical practice and research
33. Maternal confidence during toddlerhood: Comparing pre-term and full-term groups

34. Comparison of confidence between mothers who breastfed and formula fed their preterm infants
35. The determinants of parenting behavior
36. The determinants of parenting: A process model
37. Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change
38. Self-Efficacy-The Exercise of Control
39. Social support as a moderator of life stress
40. Correlates of first-time mothers' postpartum stress
41. Variables related to motherhood in normal primiparous woman
42. Psychosocial features at different periods after childbirth
43. The psychosocial consequences for primiparas and multiparas

解鎖新移民母親的適應密碼：以生態瞬時評估與穿戴式裝置探討涵化壓力、社會支持與母職適應之動態路徑

後設資料

想法編號: seed-domain-2=>2=>3=>1

新穎度: 38.2%

最大相似度: 61.8% (近似於: “Exploring the Relationship of Social Support and Postpartum Stress amongst Postpartum women in the Solomon Islands”)

群集: 5

競賽得分: 2 勝

方法論契合度: 4/5

Methodology Reasoning: Longitudinal multi-level design with repeated measures and similar constructs, but introduces acculturation stress and immigrant population, which extends the target's scope while maintaining methodological alignment.

問題陳述

隨著全球化與跨國婚姻的增加，台灣已成為多元文化社會，其中來自東南亞（如越南、印尼、菲律賓）的新移民母親已成為產科照護的重要族群。這些母親在懷孕及產後期間，同時面臨涵化壓力（如語言障礙、文化衝突、歧視經驗）與母職適應的雙重挑戰。現有研究大多依賴回顧性問卷，於單一或少數時間點測量變項，不僅存在回憶偏差，更無法捕捉日常生活中的動態波動。此外，社會支持與母職壓力在涵化壓力與產後憂鬱之間的中介與調節作用，尚未在即時、自然情境下被驗證。此問題之所以重要，是因為未能即時偵測高風險時刻，將錯失早期介入的機會，導致新移民母親及其家庭長期健康不平等。護理人員若缺乏對這些動態過程的理解，便無法設計出符合真實生活脈絡的介入措施。因此，需要一個能即時、連續且敏感地監測涵化壓力與適應指標的研究方法，以填補理論與實務之間的鴻溝。

現有方法

現有方法主要分為三類：第一類是傳統橫斷面問卷研究，如相關文獻中探討新移民母親親職壓力與憂鬱之關聯，使用單次問卷收集數據，無法揭示因果方向與時間變化。第二類是縱貫性研究，如目標論文追蹤產後婦女至四個月，但間隔時間長（月為單位），遺漏了日常生活中壓力與支持的即時波動，且依賴自我報告，易受社會期望偏誤影響。第三類是次級資料分析，如使用健保資料庫，雖有樣本數優勢，但缺乏心理社會變項的細緻測量。這些方法的共同限制包括：(1) 時間解析度不足，無法區分狀態與特質；(2) 生態效度低，回憶性數據無法反映真實情境；(3) 忽略社會網絡的結構性影響；(4) 對涵化壓力的測量多為靜態分類，未考慮其動態本質。簡而言之，現有方法無法滿足對新移民母親適應過程進行「即時、連續、多層次」剖析的需求。

研究動機

現有方法之所以不足，根本原因在於它們假定人的心理社會狀態是相對穩定的，因而採用稀疏的時間取樣。然而，涵化壓力與社會支持在本質上具有情境依賴性與時間變異性。例如，一位越南母親可能在參加社區活動時感受到強烈的社會支持，但在與公婆溝通時卻體驗到巨大的語言壓力。這些微觀事件在傳統問卷中往往被平均化或遺忘。我的靈感來自於生態瞬時評估（Ecological Momentary Assessment, EMA）與穿戴式感測技術在精神健康領域的成功應用，例如透過 GPS 移動模式預測憂鬱症狀、利用心率變異性偵測壓力反應。將這些技術應用於新移民母親，可以：(1) 捕捉壓力與支持的「即時」動態；

(2) 提供客觀的行為指標（如社交距離、活動範圍）來補充主觀報告；(3) 建立個人化的壓力觸發模型。與現有方法相比，此方法能產出高時間解析度的數據，允許我們測試「涵化壓力在何種情境下最易導致親職壓力上升」等細緻問題。此外，結合社會網絡分析，可量化不同支持來源（配偶、同鄉、台灣友人）的即時有效性。這種方法將徹底改變我們對新移民母親適應過程的理解，從靜態分類邁向動態預測。

提出方法

本提案提出「動態適應生態系統模型」(Dynamic Adaptation Ecosystem Model, DAEM)，融合生態瞬時評估 (EMA)、穿戴式生理感測、社會網絡分析與多層次結構方程模型。

****概述****：我們將招募 250 位來自越南、印尼、菲律賓的新移民母親，於懷孕 36 週至產後 6 個月期間，同時進行：(1) 每日多次的智慧型手機 EMA 問卷（隨機提示，每天 4 次），測量當下的涵化壓力（如「剛才是否感覺因口音被誤解？」）、社會支持（「剛才是否有人提供實質幫助？」）、母職壓力（「照顧寶寶讓您感到多挫折？」）與情緒狀態（0-100 視覺類比量表）；(2) 連續穿戴裝置（如 Fitbit 或 Garmin）記錄心率、心率變異性、睡眠型態、活動量與 GPS 位置；(3) 每月一次深度訪談，收集質性數據以解釋量化模式。

****步驟一：數據收集與預處理**** - 開發具文化敏感性的 EMA 題項，經專家效度與前測（20 位新移民母親）修訂。- 穿戴裝置數據以 30 秒間隔記錄，GPS 數據經匿名化處理（僅保留語意位置，如「自家」、「超市」、「公園」）。- 數據同步：以時間戳記將 EMA 回應與穿戴數據對齊。

****步驟二：建構個人化壓力軌跡**** - 對每位參與者，使用多層次模型（Level 1：時間點；Level 2：個人）分解涵化壓力的變異成分。- 以機器學習（如隨機森林）從穿戴數據中預測瞬間壓力事件（例如，心率變異性下降+GPS 停留在陌生區域>30 分鐘）。

****步驟三：社會網絡動態測量**** - 利用 EMA 中的「此刻與誰在一起」題項，結合 GPS 共現數據，建構每日社會網絡。- 計算網絡指標：支持密度、同質性（同族群比例）、橋接程度（跨文化連結）。

****步驟四：多層次結構方程模型 (MSEM) **** - 檢驗路徑：Level 1（時間內）：當下的涵化壓力→瞬間母職壓力→即時情緒；Level 2（個人間）：平均涵化壓力→社會支持（網絡指標）→母職壓力→產後憂鬱（EPDS 每月測量）。- 調節效果：以潛在成長曲線模型將涵化策略（整合、分離等）作為時間不變協變量，檢驗其對 Level 1 斜率（壓力-壓力反應強度）的影響。

****步驟五：即時回饋系統（選項）**** - 開發一個低強度的介入：當模型預測參與者處於高壓力風險（如心率變異性低、孤立時間長），自動傳送簡訊提供社會資源或放鬆技巧。- 以隨機對照試驗（一半參與者接收回饋，一半無）評估其效果。

此方法與現有研究的最大區別在於：(1) 時間解析度從「月」提升到「小時」；(2) 結合主客觀數據以降低偏誤；(3) 納入即時社會網絡動態。

實驗計畫

****步驟一：準備階段（第 1-3 個月）**** - 開發與前測 EMA 題項：從文獻與焦點團體（8-10 位新移民母親）中產生初始題庫，經 5 位專家（護理、心理、人類學）進行內容效度評定（CVI>0.8）。招募 20 位新移民母親進行為期一週的 EMA 前測，評估題項的可理解性與負擔（完成率>80%為合格）。- 選擇穿戴裝置：採用 Garmin Vivosmart 5（具心率、HRV、GPS、睡眠偵測），並進行為期一週的佩戴可行性測試。

****步驟二：正式招募與數據收集（第 4-18 個月）**** - 招募：於北、中、南三家醫院（醫學中心與區域醫院）的產科門診，透過多語言海報與通譯人員，邀請符合條件（懷孕 28-32 週、第一代新移民、無嚴重產科合併症）的母親。目標樣本 250 人，考慮 20%流失率，需招募 300 人。- 數據收集：- 基線（36 週）：人口學變項、涵化策略問卷（Bicultural Involvement Questionnaire）、社會支持量表。- EMA 期（36 週至產後 6 個月）：每日 4 次隨機提示（上午、下午、傍晚、睡前），每次 2 分鐘完成。穿戴裝置全天配戴。- 每月一次：EPDS（愛丁堡產後憂鬱量表）、PSI-SF（親職壓力簡表）。- 每月一次：30 分鐘質性訪談（選擇 10%的參與者），聚焦於壓力事件與支持經驗。- 數據管理：使用 EMA 平台（如 ExpiWell）自動上傳數據，穿戴裝置數據透過雲端同步。

****步驟三：數據分析（第 19-24 個月）**** - 數據清理：排除完成率<60%的參與者，處理缺失值（多重插補）。- 建構多層次模型：使用 Mplus 8.0 進行 MSEM，設定 Level 1（EMA 層）與 Level 2（個人層）。- 機器學習預測：以 Python scikit-learn 訓練隨機森林模型，從穿戴特徵（HRV、步數、位置多樣性）預測 EMA 壓力分數，評估 AUC>0.7 為成功。- 假設驗證：中介效應以蒙地卡羅信賴區間檢驗；調節效應以交互作用項的顯著性判斷。

****步驟四：結果解釋與應用（第 25-30 個月）**** - 成果指標：- 成功證明「涵化壓力→母職壓力」路徑在個人內層級顯著（ $\beta > 0.3, p < 0.05$ ）。- 社會支持（網絡密度）對壓力路徑的緩衝效應顯著（調節係數<0）。- 整合型涵化策略者對壓力更具韌性（斜率較平緩）。- 比較基線：與傳統縱貫研究（僅每月測量）相比，EMA 方法能解釋額外 15%的產後憂鬱變異。- 輸出：撰寫三篇論文（方法學、主要結果、介入設計），投稿至 Journal of Nursing Research 或 Journal of Clinical Nursing。

可信新穎度 — 最接近的真實論文

- Exploring the Relationship of Social Support and Postpartum Stress amongst Postpartum women in the Solomon Islands (61.8% · airtiti.AL, 2018) — 區隔明確: 該論文僅探討社會支持與產後壓力的橫斷面關聯，使用傳統問卷於單一時間點測量。本提案則採用生態瞬時評估 (EMA) 與穿戴式裝置，連續追蹤涵化壓力、社會支持與母職適應的即時動態變化，並納入心率變異性等生理指標及 GPS 位置數據，能捕捉日常生活中的波動與情境脈絡，而非僅是靜態相關。
- Postrartum Adjustment of Women who were Home During the "Traditional Chinese one Month Postrartum Period of Confinement" and Those who were in Maternity Care Centers (61.0% · airtiti.AL, 1994) — 區隔明確: 該論文比較居家坐月子與產後護理機構的產後適應差異，採用重複測量設計但僅於兩個時間點（產後 1 週與 4 週）收集問卷數據。本提案聚焦於新移民母親的涵化壓力與母職適應，使用每日多次 EMA 與連續穿戴裝置，追蹤長達 6 個月的動態路徑，並結合社會網絡分析與多層次結構方程模型，研究問題與方法均截然不同。
- [The Effectiveness of an Early Parental Sensitivity Intervention on Attachment, Parenting Confidence, and Parental Stress in Mothers of Preterm Infants]. (59.9% · airtiti.PubMed, 2025) — 區隔明確: 該論文探討早產兒母親的早期親職敏感性介入對依附關係、育兒信心與壓力的效果，為介入性研究，對象為早產兒母親。本提案則以新移民母親為對象，聚焦於涵化壓力、社會支持與母職適應的動態路徑，使用 EMA 與穿戴裝置進行觀察性研究，不涉及介入措施，研究對象與核心問題均不同。

參考文獻

1. Discharge planning, social support, postpartum depression, and maternal confidence: A correlation study among mothers of preterm infants
2. A Compare of The Postpartum Depression Related Factors in Early Postpartum Women With or Without Depression.
3. Factors related to the mental health of postpartum mothers : focusing on the relationship between child-rearing stress and self-efficacy
4. 初產婦與經產婦之心理社會影響
5. Relationship between the First Ovulation within Three Weeks Postpartum and Subsequent Ovarian Cycles and Fertility in High Producing Dairy Cows
6. Immigrant Women & Postpartum Depression

7. A APIM Study of Interpersonal Adaptation and Culture Identity Between New Immigrant Parents and Children
8. The Relationship between Parenting Stress and Depression of New Southeast Asian Immigrant Mothers - Social Support as Moderator
9. Validation Assessment and Latent Profile Analysis on the Acculturation Scale for Foreign Students' in Taiwan
10. Acculturation Theory and New Immigrant Women's Health: Nursing Implementations
11. S6-2 "Bonding Disorder" Among Mothers with Postnatal Depression(ISPOG2007)
12. Relationships Among Early Development of Preterm Infants , Postnatal Depression and the Postpartum Bonding
13. Relationships among parental attachment, postpartum depression and the mother-infant bonding
14. The associations among mother-infant relationship, postpartum depression and perinatal psychosocial status
15. Predictors of and Changes in Postpartum Depression and Mother-Infant Bonding
16. Developmental trajectories of infant nighttime awakenings are associated with infant-mother and infant-father attachment security.
17. Relationships between Social Supports, Maternal Confidence, Maternal Competence, and Maternal Parenting Stress in the Postpartum Period of Postpartum Women : Multilevel Analysis
18. Maternal Confidence at Infant Discharge: Comparing Preterm and Fullterm Groups

Postpartum Women .

en After a Stillbirth .

19. Under the policy of mother-baby friendly, postpartum women' s Fatigue, baby-care activities and maternal-infant attachment with different types of delivery.
20. Mental health in mothers at 1-2 months postpartum
21. A Correlational Study of Breastfeeding Self-Efficacy, Maternal Confidence, and Mother-Infant Attachment in Postpartum Wome
22. Building a nest in a storm: The impact of immigration-related stress on Latino mothers' parenting.
23. Enmeshment or disengagement—The Study of boundary between parent and child in Taiwan college students
24. Risk and protective factors for pre- and postnatal bonding.
25. The Influence of Confinement Location on Maternal Psychological and Role Adaptation: A Six-Month Follow-Up Study

26. The biological perspective on mother-infant bonding: the importance of oxytocin
27. The Nature and Assessment of Mother-Infant Bonding Disorders
28. The Postpartum Experience of Vietnamese Spouses
29. Exploring the Relationship of Social Support and Postpartum Stress amongst Postpartum women in the Solomon Islands
30. An Exploratory Study of the Postpartum Stress and its Related Factors
31. Analysis of the Construct of Postpartum Stress
32. Depression and Stress of Women and Their Spouses During the Postpartum Period
33. The Study on Gay's Homosexual Identity, Couple Relationship Satisfaction, and Perceived Social Support.
34. Relationships Among Marital Adjustment, Communication Patterns, Social Support, and Paternal Postpartum Depression
35. The Relationships among Personality Constructs, Social Cultural Factors, and Postpartum Depression
36. Proposals for improving maternal safety (2023 edition): Insights from the analysis of maternal deaths in Japan.
37. The Relationship Between Social and Economic Environments of Cities/Counties and the Depressive Symptoms of Taiwanese Adults: A Multilevel Analysis
38. Further psychometric testing and use of the Maternal Confidence Questionnaire
39. Sources of maternal confidence and uncertainty and perceptions of problem-solving competence
40. Maternal confidence, knowledge, and quality of mother – toddler interactions: a preliminary study
41. Maternal confidence in toddlerhood: Its measurement for clinical practice and research
42. Maternal confidence during toddlerhood: Comparing pre-term and full-term groups
43. Comparison of confidence between mothers who breastfed and formula fed their preterm infants
44. The determinants of parenting behavior
45. The determinants of parenting: A process model
46. Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change
47. Self-Efficacy-The Exercise of Control
48. Social support as a moderator of life stress
49. Correlates of first-time mothers' postpartum stress

50. Variables related to motherhood in normal primiparous woman
51. Psychosocial features at different periods after childbirth
52. The psychosocial consequences for primiparas and multiparas

整合虛擬實境家庭教練與神經同步性生物標記之家庭中心介入對極低出生體重早產兒父母親職壓力長期軌跡的影響：一項混合方法隨機對照試驗

後設資料

想法編號: seed-theory-4=>3=>2=>3

新穎度: 23.5%

最大相似度: 76.5% (近似於: “[The Effectiveness of an Early Parental Sensitivity Intervention on Attachment, Parenting Confidence, and Parental Stress in Mothers of Preterm Infants].”)

群集: 9

競賽得分: 2 勝

方法論契合度: 4/5

Methodology Reasoning: Longitudinal RCT with repeated measures and similar outcomes (stress, confidence, competence); includes multi-level analysis potential; but targets parents of VLBW infants and adds intervention, extending beyond target’s observational design.

問題陳述

極低出生體重 (<1500 公克) 早產兒的父母面臨巨大的親職壓力，這會損害其心理健康、親子關係及兒童長期發展。雖然過去研究已證實以家庭為中心的介入（如產後照護協調、居家訪視）能短期降低壓力，但這些介入的長期效果（超過 12 個月）仍未知。更重要的是，現有研究忽略了兩個關鍵面向：第一，父親的角色經常被排除在外，但父親的壓力與信心同樣影響家庭動態；第二，親職信心與能力的變化如何隨時間調節壓力，其神經生物學機制完全未被探討。台灣的縱貫研究（目標論文）已指出社會支持、信心、能力與壓力之間有時間動態關係，但缺乏將這些心理變項與客觀神經指標連結的研究。因此，本計畫旨在填補此缺口，並引入創新技術來提升介入的個人化與效能。

現有方法

現有介入多採用標準化教育課程、電話追蹤或定期家訪。例如，台灣研究使用出院衛教錄影帶、家庭為中心的照護模式（如那篇以家庭為中心介入對早產兒父母親職壓力之長期療效），這些方法已被證實有效，但局限性明顯：第一，它們缺乏即時、個人化的回饋——父母在照顧嬰兒時遇到的突發問題無法立即獲得指導。第二，效果評估多依賴自陳式量表（如親職壓力量表、母育信心量表），容易受到回憶偏誤和社會期望偏差影響。第三，這些介入忽略了父母-嬰兒互動時的大腦層面變化，無法解釋為什麼有些父母雖然知識增加但壓力未減。第四，長期追蹤僅限於問卷，未能捕捉壓力軌跡背後的動態機制。因此，現有方法不足以全面理解介入如何從神經到行為層面改善親職結果。

研究動機

現有方法之所以不足，是因為它們將親職壓力視為靜態結果，而非動態歷程，且未利用現代科技提供精準介入。本提案的靈感來自兩個新興領域：第一，神經科學中的雙腦同步性（interpersonal neural synchrony）研究顯示，當照顧者與嬰兒互動時，雙方的前額葉皮質活動會同步，此同步性與照顧者的同理心、情緒調節及照顧品質正相關。我們推測，親職信心與能力的提升，本質上會增強父母與嬰兒的腦間同步，進而降低壓力。第二，虛擬實境（VR）在醫療訓練中已顯示能有效提升技能與自信，因為它提供安全、可重複的模擬環境。因此，我們提出一個『VR 家庭教練』系統：父母戴上 VR 頭盔，在虛擬家中練習照顧早產兒（如餵奶、洗澡、處理哭鬧），系統透過內建感測器（眼球追蹤、手部動作）即時評估其表現，並提供語音指導。同時，父母與嬰兒在真實互動時佩戴功能性近紅外光譜（fNIRS）帽，

測量前額葉腦區的血氧濃度變化，計算雙腦同步性指標。我們假設，VR 訓練能加速信心與能力的增長，而神經同步性的增加會中介壓力的下降。這個方法比傳統介入更個人化、更客觀，且能揭示壓力變化的神經機制。

提出方法

本提案為一項多中心、雙盲（評估者盲）、隨機對照試驗，結合混合方法設計。

****研究對象****：於北、中、南三家醫學中心新生兒加護病房（NICU）招募 200 對極低出生體重早產兒（出生體重<1500 公克，無重大先天異常）的父母（母親與父親均納入）。排除條件為父母有嚴重精神疾病、藥物濫用或無法使用 VR 設備者。

****介入組（n=100 對）****：接受為期 12 個月的『VR 家庭教練』介入，包含三個階段：1. NICU 住院期（出院前 2 週）：父母每週進行 2 次 VR 模擬訓練，每次 30 分鐘。VR 內容根據嬰兒當下發展階段（如矯正年齡）動態調整，涵蓋袋鼠護理、奶瓶餵食、臍帶護理、辨識嬰兒飢餓訊號等。系統記錄父母的操作錯誤率與反應時間，並在每次訓練後生成『信心指數』（由 AI 模型根據表現預測）。2. 返家後第 1-6 個月：每週 1 次 VR 訓練（主題轉為居家安全、發展促進活動如 Tummy Time、睡眠安撫），並搭配每 2 週一次的遠距視訊教練會議（由研究護理師主持，討論 VR 訓練中的困難）。3. 第 7-12 個月：每 2 週 1 次 VR 訓練（主題為副食品添加、分離焦慮處理、語言刺激），每月一次線上家長支持團體（由臨床心理師引導）。

****對照組（n=100 對）****：接受標準照護，包括 NICU 出院準備教育、常規門診追蹤及書面衛教手冊。

****數據收集（所有時間點）****：於矯正年齡足月（T0）、6 個月（T1）、12 個月（T2）、24 個月（T3）、48 個月（T4）進行。- ****主要結果****：親職壓力（Parenting Stress Index-Short Form, PSI-SF）- ****次要結果****：親職信心（Maternal/Paternal Confidence Questionnaire）、親職能力（自編勝任感量表）、社會支持（Social Support Scale）、父母心理健康（憂鬱、焦慮量表）- ****創新指標****：在 T0、T2、T4 時，父母與嬰兒進行 10 分鐘自由遊戲互動，同時雙方佩戴 fNIRS 頭帽（NIRx NIRSport2，8x8 光極配置於前額葉與顳葉）。計算父母-嬰兒前額葉血氧濃度信號的交叉相關性（wavelet transform coherence）作為雙腦同步性指標。- ****質性資料****：在 T2 與 T4 時，對介入組進行半結構式深度訪談（每組隨機選取 15 對父母），探討他們對 VR 介入的經驗、壓力變化與親子關係的感知。

****統計分析****：使用多層次成長模型（multilevel growth modeling）檢驗兩組在壓力、信心、能力上的軌跡差異。以路徑分析（path analysis）測試中介模型：介入→信心/能力變化→神經同步性變化→壓力變化。質性資料採用主題分析法，並與量化結果進行三角驗證。

****創新增量****：第一，這是首次將 VR 與神經同步性結合應用於早產兒親職介入。第二，同時納入父親並進行雙親分析，檢驗母親與父親的壓力軌跡是否不同。第三，使用 fNIRS 提供客觀生物標記，可望成為未來臨床評估工具。

實驗計畫

****第一步：研究準備與倫理審查****（第 1-3 個月）- 開發 VR 內容：與遊戲設計公司合作，使用 Unity 引擎製作三階段 VR 訓練模組，邀請 10 名早產兒父母進行前導測試，調整內容難度與文化適切性。- 培訓研究護理師：進行 VR 系統操作、fNIRS 佩戴、遠距教練技巧的標準化訓練。- 申請三家醫院的 IRB 核准。

****第二步：招募與隨機分派****（第 4-18 個月）- 在 NICU 張貼招募海報，由個案管理師篩選符合條件的家庭。- 取得知情同意後，使用電腦隨機序列（分層隨機化，依出生體重<1000g vs 1000-1500g 及醫院別）將 200 對父母分派至介入組或對照組。

****第三步：介入執行****（第 4-30 個月）- 介入組：VR 教練系統於研究平板電腦上運行，父母每週獲得訓練提醒。研究助理每周監控使用數據，若連續 2 週未使用則電話提醒。- 對照組：接受標準照護，並在每次評估後獲得小額禮券作為參與獎勵。

****第四步：資料收集****（第 4-60 個月）- 時間點：T0（足月）、T1（6 個月）、T2（12 個月）、T3（24 個月）、T4（48 個月）。- 每次收集時，父母填寫電子問卷（使用 REDCap）。fNIRS 僅在 T0、T2、

T4 時於醫院進行標準化互動任務。- 質性訪談於 T2 與 T4 後一個月內進行，全程錄音轉謄。

****第五步：數據分析****（第 36-66 個月）- 量化分析：使用 SAS PROC MIXED 進行多層次成長模型，檢驗組別 × 時間交互作用。路徑分析使用 Mplus，以 Bootstrap 法檢驗中介效應。神經同步性數據使用 MATLAB 的 FieldTrip 工具包進行預處理（去除運動偽影、帶通濾波 0.01-0.1Hz），計算相干性。- 質性分析：使用 NVivo 14 進行主題分析，由兩位研究者獨立編碼，達成共識。

****第六步：結果詮釋與發表****（第 60-72 個月）- 整合量化與質性結果，撰寫論文投稿至《International Journal of Nursing Studies》或《Journal of Clinical Nursing》。

****成功指標****：- 介入組在 T2、T3、T4 時的 PSI-SF 分數顯著低於對照組（效應量 Cohen's $d > 0.4$ ）。- 路徑分析顯示，信心與能力的提升顯著預測神經同步性增加，進而預測壓力下降。- 質性訪談中，介入組父母報告 VR 訓練提升其準備感與親密感。

****潛在挑戰與應對****：- 退出率（預估 30%）：提供多元聯絡方式（Line、電話）、每次評估補助交通費 500 元。- fNIRS 設備故障：配置備用機，並定期維護。- VR 暈動症：在訓練前進行適應性測試，並提供休息選項。

可信新穎度 — 最接近的真實論文

- [The Effectiveness of an Early Parental Sensitivity Intervention on Attachment, Parenting Confidence, and Parental Stress in Mothers of Preterm Infants]. (76.5% · airtiti.PubMed, 2025) — 高度重疊：該論文為針對早產兒母親的早期敏感性介入隨機對照試驗，僅測量產後 6 個月內的依附、信心與壓力，且未納入父親。本提案則納入父母雙方，追蹤至 48 個月，並加入 VR 家庭教練與 fNIRS 神經同步性生物標記，探討親職壓力長期軌跡及其神經機制，研究問題與方法有根本差異。（相似度 76% 偏高，標籤經相似度守衛下修）
- Systematic review of the literature on postpartum care: effectiveness of postpartum support to improve maternal parenting, mental health, quality of life, and physical health. (66.5% · airtiti.PubMed, 2006) — 增量：該系統性回顧聚焦產後支持對母親育兒、心理健康與生活品質的短期效果，未針對極低出生體重早產兒父母，也未使用 VR 技術或神經生物標記。本提案為隨機對照試驗，結合 VR 教練與 fNIRS，追蹤至 48 個月，並同時納入父親，研究設計與切入角度截然不同。（相似度 66% 偏高，標籤經相似度守衛下修）
- [Parenting and Nursing Issues Faced by Parents During the Hospitalization of Their Preterm Infants]. (66.4% · airtiti.PubMed, 2016) — 增量：該論文為描述性文獻探討，整理早產兒住院期間父母的育兒與護理議題，未提出介入方案或實證數據。本提案為混合方法隨機對照試驗，實際測試 VR 家庭教練介入對親職壓力長期軌跡的影響，並收集量化與質性資料，研究類型與貢獻有本質差異。（相似度 66% 偏高，標籤經相似度守衛下修）

參考文獻

1. Parenting and Nursing Issues Faced by Parents During the Hospitalization of Their Preterm Infants
2. Maternal Confidence at Infant Discharge: Comparing Preterm and Fullterm Groups
3. Effectiveness of Videotape Education for Mothers of Prematurity
4. Concept Analysis of Maternal Confidence
5. 以家庭為中心介入對臺灣早產兒父母親職壓力之長期療效
6. Trend of preventive management of preterm birth

7. Paternal Effects in Mammals: Challenges and Opportunities.
8. The Lived Experience of Jordanian Parents in a Neonatal Intensive Care Unit: A Phenomenological Study
9. Pathways of Care: A longitudinal study of children in care in Australia: Introductory article for special issue on Pathways of Care Longitudinal Study.
10. Relationships between Social Supports, Maternal Confidence, Maternal Competence, and Maternal Parenting Stress in the Postpartum Period of Postpartum Women : Multilevel Analysis
11. Discharge planning, social support, postpartum depression, and maternal confidence: A correlation study among mothers of preterm infants
12. Dyadic analysis of illness perceptions among individuals with stroke and their caregivers: effects on activity engagement in community living.
13. Risk and protective factors for pre- and postnatal bonding.
14. Effects of male postpartum depression on father-infant interaction: The mediating role of face processing.
15. The Determinants of Parental Stress and Care Needs among Parents with VLBW and ELBW Preterm Infants- A Longitudinal Study
16. Parents' Personality, Social Support, Stress Response, and Psychological Response to Their Premature Infant in a Neonatal Intensive Care Unit
17. A Study on Parenting Stress, Social Supports and Parenting Behaviors of Kindergarten Parents in Taichung Area
18. "Weathering the storm:" Mothers' and fathers' experiences of parenting a preterm infant.
19. Effects of Discharge Planning on the Knowledge, Competence, and Maternal Confidence of the Mother with Preterm Infant
20. Maternal morbidity and mortality: an iceberg phenomenon.
21. Effectiveness of a Nurse-Led Web-Based Health Management in Preventing Women With Gestational Diabetes From Developing Metabolic Syndrome
22. Parental Stress in the Neonatal Intensive Care Unit (NICU)
23. Effectiveness of Virtual Reality Application on Delirium and Anxiety in Elderly Patients in Intensive Care Unit
24. Intervention and Evaluation of a Pre-graduation Stress Management Program for Reducing "Reality Shock" among Nursing Students
25. Influence of Feeding Interaction Program on Maternal Feeding Behaviors with Preterm Infant
26. Effect of Early Intervention to Promote Mother - Infant Interaction and Maternal Sensitivity in Japan: A Parenting Support Program based on Infant Mental Health

27. A longitudinal study of paternal mental health problems from the antenatal to the postpartum period: riskfactors, relationship with maternal factors and impact of gender role and traditionalism-modernity
28. SUPPORT-SEEKING BEHAVIOR AMONG JAPANESE MOTHERS AT HIGH-RISK OF MENTAL HEALTH PROBLEMS: A COMMUNITY-BASED STUDY AT A CITY HEALTH CENTER
29. Home Care Needs and Confidence of Mothers of Premature Infants during Early Discharge Period

for Preterm Infants .

y Eye Examinations .

30. The state of psychosocial of women during pregnancy and 2 years after birth : A relationship between MCQ, EPDS and GHQ
31. S1-3 Psychosocial Aspects of Postpartum Depression in the United States(ISPOG2007)
32. ESSENTIAL STEPS FOR LATENT GROWTH CURVE MODELING IN TAIWANESE PANEL STUDY
33. I.Mothers with late preterm infant decrease health-related quality of life at 18 months of age: A population-based cohort study II.Longitudinal change of health-related quality of life experienced by mother with late preterm infants
34. Mother-infant intervention to promote maternal mental health after preterm birth
35. Exploring the Relationship of Social Support and Postpartum Stress amongst Postpartum women in the Solomon Islands
36. Proposals for improving maternal safety (2023 edition): Insights from the analysis of maternal deaths in Japan.
37. An Exploratory Study of the Postpartum Stress and its Related Factors
38. A Compare of The Postpartum Depression Related Factors in Early Postpartum Women With or Without Depression.
39. Psychometric properties of thePsychosocial Screen for Cancer-Revised(PSSCAN-R)in Taiwan

ress and Depression .

s of Preterm Infants .

40. Further psychometric testing and use of the Maternal Confidence Questionnaire
41. Sources of maternal confidence and uncertainty and perceptions of problem-solving competence
42. Maternal confidence, knowledge, and quality of mother – toddler interactions: a preliminary study
43. Maternal confidence in toddlerhood: Its measurement for clinical practice and research

44. Maternal confidence during toddlerhood: Comparing pre-term and full-term groups
45. Comparison of confidence between mothers who breastfed and formula fed their preterm infants
46. The determinants of parenting behavior
47. The determinants of parenting: A process model
48. Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change
49. Self-Efficacy-The Exercise of Control
50. Social support as a moderator of life stress
51. Correlates of first-time mothers' postpartum stress
52. Variables related to motherhood in normal primiparous woman
53. Psychosocial features at different periods after childbirth
54. The psychosocial consequences for primiparas and multiparas

「連結・看見・賦權」：一項混合數位配對與社區儀式性家訪的社會支持介入對高風險產後婦女憂鬱、母嬰連結與育兒信心之效果

後設資料

想法編號: seed-theory-4=>1=>1=>1

新穎度: 24.4%

最大相似度: 75.6% (近似於: “[The Effects of a Mobile Application Social Support Program on Postpartum Perceived Stress and Depression].”)

群集: 6

競賽得分: 1 勝

方法論契合度: 2/5

Methodology Reasoning: Mixed-methods quasi-experimental intervention study with digital and community components. Focus on high-risk depression and bonding. Methodology diverges from target’s observational multi-level approach.

問題陳述

產後憂鬱症是產後婦女最常見的精神健康問題，盛行率約 10-15%，對母親、嬰兒及家庭造成深遠負面影響，包括母嬰連結障礙、育兒信心低落、甚至嬰兒發展遲緩。台灣研究指出，社會支持是產後憂鬱的重要保護因子，但現有支持系統存在明顯斷裂：產後初期婦女從醫療機構返家後，支持網絡急遽縮減，特別是高風險婦女（如 EPDS 高分、低社會經濟地位、單親或未成年母親）更容易陷入孤立。目標論文（Chen et al., 2021）顯示社會支持隨時間遞減，而母職壓力在產後一個月達到高峰，凸顯了及時介入的重要性。然而，現有介入多為單一模式：行動健康 App 雖能提供資訊，但缺乏人際溫度與在地連結；傳統家訪雖有效，但人力成本高、涵蓋率低，且常流於標準化指導，未能針對個別婦女的社會網絡進行深度工作。此外，多數介入聚焦於症狀減輕，而非同時強化母親的內在資源（如母育信心、母嬰關係）與外在資源（如同儕支持、社區連結）。在後疫情時代，數位工具普及但社會孤立加劇，迫切需要一種既能發揮數位便利性、又能創造深度人類連結的混合介入模式。本研究的問題在於：如何設計一個兼具數位社交配對、即時心理教育，以及以嬰兒心理健康為基礎的儀式性家訪之混合介入，來有效提升高風險產後婦女的社會支持、降低憂鬱、增強母嬰連結與育兒信心？這問題具臨床重要性，因為若能成功，將可填補現有支持系統的斷裂，並提供可擴展、成本效益高的解決方案，對台灣及全球產後心理健康照護產生重大影響。

現有方法

現有方法主要分為三類：第一，純數位介入，如基於 Line 的行動應用程式社會支持方案（如相關文獻第七篇），透過群組聊天、影片衛教、壓力管理工具提供支持。其優勢為低成本、高可及性，但限制在於缺乏真人即時互動，且容易因使用頻率降低而失效；參與者常感到「虛擬支持」不足以取代真實擁抱或眼神交流。第二，純家訪介入，如日本針對早產兒母親的早期干預（相關文獻第二篇），由受訓護理師到府指導互動技巧。其效果顯著，但需大量人力資源，難以大規模推廣，且常忽略數位工具能提供的同儕網絡與持續監測。第三，團體介入，如夫妻聚焦的產後憂鬱預防方案（相關文獻第八篇），透過結構化課程增進溝通與支持。這類方法有效，但招募與維持參與者困難，特別是高風險婦女常因育兒壓力或交通問題無法出席。現有方法的共同限制為：缺乏動態配對機制（無法根據個別需求即時連結同儕）、未將社會網絡視為介入標的（只提供支持而非強化既有網絡）、以及未能結合數位與人類互動的互補優

勢。目標論文的多層次分析雖揭示了社會支持與母育信心的縱貫關係，但未提出具體介入方案。因此，本研究的提案旨在克服這些限制，創造一個整合數位配對、AI 即時回應與儀式性家訪的全新模式。

研究動機

現有方法之所以不足，是因為它們假設支持可以單向提供（如 App 推送資訊）或標準化傳遞（如家訪手冊），但忽略了支持的本質是關係性的、情境化的。高風險產後婦女需要的不是更多的資訊，而是被看見、被連結、被賦權的經驗。我的靈感來自於「社會處方籤」（social prescribing）與「象徵互動論」（symbolic interactionism）的概念：支持必須嵌入於個人的生活脈絡中，並透過有意義的儀式來深化。因此，我設計的混合介入包含兩個創新元素：(1) 數位配對平台——不同於現有 App 的公開論壇，本平台使用演算法根據 EPDS 分數、嬰兒月齡、興趣（如哺乳、睡眠）將婦女配對成 4-5 人的「支持小組」，並由 AI 聊天機器人引導每週主題討論，確保互動深度。這項設計基於「同質性原則」（homophily），預期配對後的支持更有效。(2) 儀式性家訪——不同於傳統家訪的指導性，三次家訪各有一個象徵性主題：「看見你」：護理師與母親共同觀看 30 秒的母嬰互動影片，使用「影片回饋」（Video-Feedback）技術，幫助母親發現嬰兒的線索並增強敏感性；「連結網」：協助母親繪製她的社會支持網絡圖，並具體規劃如何強化一個弱連結（如與鄰居的互動）；「賦權」：母親自己設計一份「自我照顧合約」，護理師從旁協助而非主導。這方法預期會比純 App 或純家訪更好，因為它同時提供了數位的即時連結與人類的深度共鳴，並且直接作用於社會支持網絡的結構與品質。目標論文指出社會支持隨時間遞減，而本介入透過持續的數位小組互動與三次家訪的里程碑，可望逆轉此趨勢，形成一個「支持加速度」效應。此外，本提案大膽地將「儀式」引入護理介入，這是現有文獻中鮮少探討的，但卻符合人類學中儀式能強化社群連結與個人轉變的理論。

提出方法

本提案為一項混合方法、準實驗設計的介入研究，旨在發展與測試「連結·看見·賦權」混合介入方案。以下為詳細步驟：

****方案概述****：介入為期 6 個月，包含兩個並行組件：(1) Line-based「媽咪連結」平台——一個結合 AI 配對、聊天機器人引導的私密支持小組；以及 (2) 三次由受過嬰兒心理健康與影片回饋訓練的社區護理師執行的儀式性家訪（於介入第 1、2、4 個月進行）。對照組接受常規產後照護（通常包括產後門診衛教與電話關懷）。

****步驟一：平台設計與 AI 配對演算法**** - 開發 Line 聊天機器人（使用 Line Messaging API），命名為「小幫手」。
- 配對演算法：參與者在加入時填寫基線問卷（包含 EPDS、嬰兒月齡、主要育兒困擾如睡眠/哺乳/情緒）。演算法使用 K-means 聚類將相似婦女分組為 4-5 人小組。
- 每週聊天機器人推送一個主題（如「這週試著觀察寶寶的細微表情」），並提供互動式練習（如「請分享一張你與寶寶的合照，並描述當時的感覺」）。
- 聊天機器人內建「紅旗偵測」：若偵測到關鍵字如「想傷害自己」或 EPDS 再測分數 ≥ 15 ，會自動通知研究護理師進行緊急聯繫。
- 平台另設「知識庫」：內含影片、文章，主題包括壓力管理、嬰兒線索解讀、社會資源連結。

****步驟二：儀式性家訪手冊與護理師訓練**** - 發展標準化家訪手冊，每次家訪 90 分鐘，包含三個儀式：
1. ****第一次家訪（介入第 1 個月）：「看見你」儀式**** - 護理師攜帶平板電腦，請母親與嬰兒進行 5 分鐘自由互動（如餵奶、換尿布、玩遊戲），並錄影。
- 共同觀看影片，護理師使用「影片回饋法」：暫停影片，指出母親的敏感行為（如「你看，寶寶轉頭時，你立刻調整了姿勢，他看起來更放鬆了」）。
- 目的：增強母嬰互動敏感性與母親的自我效能感。
2. ****第二次家訪（介入第 2 個月）：「連結網」儀式**** - 使用「生態圖」（Eco-map）工具，請母親畫出她的社會支持網絡（家人、朋友、鄰居、專業人員）。
- 護理師引導討論：「哪一條線最弱？你可以做一件小事來強化它嗎？」（例如：主動邀請鄰居喝杯茶）。
- 共同規劃一個「連結行動」，並在下次家訪時回顧。
3. ****第三次家訪（介入第 4 個月）：「賦權」儀式**** - 母親主導：她需事先準備一份「自我照顧合約」，內容包括「我承諾每週做一件只為自己的事」（如閱讀 15 分鐘、散步）。
- 護理師的角色是見證與鼓勵，而非指導。結束時，護理師遞給母親一個「連結證書」，象徵她成為自己支持的專家。
- 護理師訓練：8 小時課程，包含影片回饋技巧、生態圖使用、紅旗

辨識與倫理議題。

****步驟三：整合與個人化**** - 平台與家訪相互補充：家訪中討論的主題（如連結行動）會由聊天機器人追蹤（如「上次你計劃邀請鄰居喝茶，成功了嗎？」）。- 每組支持小組由一名研究助理擔任「小組催化員」，但僅在必要時介入（如小組冷場），鼓勵成員自主討論。

****獨特性與創意****：本提案不同於所有現有研究，因為它：(1) 將「儀式」作為介入核心，而非僅是技能訓練；(2) 使用數位配對創造同質性高的同儕群體，增強歸屬感；(3) 透過影片回饋直接作用於母嬰互動品質，這是目標論文與相關文獻未深入探討的；(4) 強調母親的主體性（自我照顧合約由母親設計），避免傳統介入的家長式作風。

實驗計畫

****步驟一：研究設計與倫理審查**** - 設計：前瞻性、混合方法、準實驗設計（對照組為常規照護）。- 倫理審查：申請台灣中部某醫學中心 IRB，確保資料安全與知情同意程序。

****步驟二：樣本招募與分組**** - 招募來源：台灣中部兩家醫院（一家醫學中心、一家區域醫院）的產後病房。- 納入條件：產後滿 2 週、EPDS 得分 ≥ 10 、年齡 ≥ 20 歲、擁有智慧型手機並會使用 Line、同意家訪。- 排除條件：目前接受精神科治療、嬰兒有重大先天異常或住 NICU、台灣語言溝通障礙。- 樣本數估算：根據目標論文效果量（社會支持與憂鬱相關 $r \approx 0.3$ ）及多層次模型需求，需至少每組 60 人（共 120 人），考慮 20% 流失率，招募 150 人。- 分組：以醫院為單位進行分組（避免污染），一家醫院為介入組、另一家為對照組，並進行醫院特性匹配。

****步驟三：介入實施**** - 介入組：按照前述方案執行，Line 平台於加入後立即啟用，家訪於第 1、2、4 個月進行。- 對照組：接受常規產後門診衛教（包含產後護理指導、哺乳諮詢）及醫院提供的電話關懷（通常於產後 1 個月一次）。- 介入忠誠度：每次家訪錄音，由研究團隊隨機抽查 20% 以確保遵從手冊。

****步驟四：資料收集**** - 測量時間點：T0（基線，產後 2 週）、T1（產後 1 個月）、T2（產後 3 個月）、T3（產後 6 個月）。- 主要結果：產後憂鬱（愛丁堡產後憂鬱量表 EPDS）、母嬰連結（產後連結問卷 PBQ）、育兒信心（母育信心量表 MCQ）。- 次要結果：社會支持（社會支持量表 SSQ）、社會網絡（個人網絡問卷）、育兒壓力（母職壓力量表）。- 質性資料：在 T3 時，對介入組進行半結構式訪談（每組選 10 位），探討「哪個介入元素最有幫助？」與「你覺得自己改變了什麼？」

****步驟五：數據分析**** - 量化分析：使用 SPSS 或 R 進行多層次模型（HLM），以時間為層次一、個體為層次二，組別為預測變項。調整基線變項（如教育程度、胎次）。效果量以 Cohen's d 呈現。- 質性分析：使用主題分析法，將訪談稿編碼，歸納出核心主題。- 混合方法整合：使用「嵌入設計」，將質性主題用於解釋量化軌跡（例如：母育信心上升的參與者是否在訪談中提及「看見你」儀式？）。

****步驟六：成功指標**** - 介入組在 T2 與 T3 的 EPDS 平均分數顯著低於對照組 ($p < 0.05$, $d \geq 0.5$)。- 介入組的 PBQ 與 MCQ 平均分數顯著高於對照組。- 社會支持得分在介入組中未隨時間下降（與目標論文趨勢相反）。- 質性訪談中出現以下主題：「我被看見了」、「連結不再孤單」、「我學會相信自己的直覺」。- 流失率低於 20%（顯示介入具吸引力）。

****步驟七：可行性與挑戰**** - 挑戰：家訪護理師招募、Line 平台開發成本、參與者數位落差。- 因應策略：與社區衛生所合作借調護理師；申請科技部計畫經費；提供數據流量補助。

可信新穎度 — 最接近的真實論文

- [The Effects of a Mobile Application Social Support Program on Postpartum Perceived Stress and Depression]. (75.6% · airtiti.PubMed, 2016) — 高度重疊：該論文僅測試一個純行動應用程式（App）的社會支持方案，而本提案則整合了 AI 配對的 Line 平台與三次實體儀式性家訪，形成混合介入模式。本提案的家訪包含影片回饋法與嬰兒心理健康為基礎的儀式設計，該論文完全未涉及此類面對面、深度互動的介入成分。此外，本提案測量母嬰連結與育兒信心，該論文僅關注壓力與憂鬱。（相似度 76% 偏高，標籤經相似度守衛下修）
- Understanding the Dynamics of Online Social Support Among Postpartum Mothers in Online Communities. (66.1% · airtiti.PubMed, 2023) — 增量：該論文為探索性質性研究，旨在了解產

後母親在線上社群中尋求與提供社會支持的動態，並未測試任何介入方案。本提案則是一項準實驗介入研究，實際開發並測試一個包含數位配對與家訪的混合介入，並量化其對憂鬱、母嬰連結與育兒信心的效果。研究問題與方法在本質上完全不同。(相似度 66% 偏高，標籤經相似度守衛下修)

- Systematic review of the literature on postpartum care: effectiveness of postpartum support to improve maternal parenting, mental health, quality of life, and physical health. (65.7% · airtiti.PubMed, 2006) — 增量: 該論文為系統性文獻回顧，綜整產後支持方案對母職、心理健康、生活品質與身體健康的效果，並未提出新的介入模式或進行原始資料收集。本提案則發展一個具體的混合介入（數位配對+儀式性家訪），並設計前瞻性準實驗研究來測試其效果，屬於原創性介入研究，而非文獻回顧。(相似度 66% 偏高，標籤經相似度守衛下修)

參考文獻

1. Effect of early intervention using state modulation and cue reading on mother-infant interactions in preterm infants and their mothers in Japan
2. Effects of Discharge Planning on the Knowledge, Competence, and Maternal Confidence of the Mother with Preterm Infant
3. A Study of Meanings of the Interactions Between Preterm Infant's Mothers and Nurses in the NICU
4. Relationships among parental attachment, postpartum depression and the mother-infant bonding
5. SUPPORT-SEEKING BEHAVIOR AMONG JAPANESE MOTHERS AT HIGH-RISK OF MENTAL HEALTH PROBLEMS: A COMMUNITY-BASED STUDY AT A CITY HEALTH CENTER
6. The Effects of a Mobile Application Social Support Program on Postpartum Perceived Stress and Depression
7. Couple-Focused Postpartum Depression Prevention Group Program for New Parents
8. 嬰兒氣質、母乳哺餵經驗與產後憂鬱之相關探討
9. Depression status of couples from birth until 1 month postpartum
10. Prevention of preterm birth: Proactive and reactive clinical practice-are we on the right track?
11. Parenting and Nursing Issues Faced by Parents During the Hospitalization of Their Preterm Infants
12. Proposals for improving maternal safety (2023 edition): Insights from the analysis of maternal deaths in Japan.
13. THE DEVELOPMENT OF INFANT TEMPERAMENT AND ITS RELATIONSHIP WITH MATERNAL TEMPERAMENT
14. The link between maternal perinatal mood disturbances and infant health outcomes

15. The Michigan infant mental health home visiting model.
16. Discharge planning, social support, postpartum depression, and maternal confidence: A correlation study among mothers of preterm infants
17. Relationships Among Early Development of Preterm Infants , Postnatal Depression and the Postpartum Bonding
18. Relationships Between Postpartum Stress, Social Support, and Depression, and Health Status of the Premature Infant’ s Mother.
19. The Application of Watson’s Theory in Nursing Experience in a Child Patient with Enter Virus Infection
20. Applying Watson’s Theory to Caring for a Child with Open Leg Fracture and His Primary Caregiver
21. The Nature and Assessment of Mother-Infant Bonding Disorders
22. Applying Swanson’s Caring Theory for a Preterm Infant and a Postpartum Depressed Mother
23. Oral Feeding Intervention Guidelines of Preterm Infant
24. Effect of Early Intervention to Promote Mother - Infant Interaction and Maternal Sensitivity in Japan: A Parenting Support Program based on Infant Mental Health
25. Parenting Stress and Coping Strategies in Caregivers of Preschool Children with Autism Spectrum Disorder
26. Research priorities for care of preterm or low birth weight infants: health policy.
27. Exploring the Relationship of Social Support and Postpartum Stress amongst Postpartum women in the Solomon Islands
28. Maternal Confidence at Infant Discharge: Comparing Preterm and Fullterm Groups
29. Internal Factors that Impact the Attachment-Caregiving Balance from Mother to Infant— The Impact of a Mother’ s Parental Bonding Experience and Internal Working Model—
30. The Relationships between Dyadic Dissensus, Individual-Social Orientation Conflict, Sociotropic Dysfunctional Attitudes, and Postpartum Depressive Symptoms
31. The Determinants of Parental Stress and Care Needs among Parents with VLBW and ELBW Preterm Infants- A Longitudinal Study
32. A Study on the Parental Stresses and the Needs of Early Intervention Service of Mothers with Premature Babies
33. 以家庭為中心介入對臺灣早產兒父母親職壓力之長期療效
34. Mother-infant intervention to promote maternal mental health after preterm birth
35. Trajectory of blood pressure levels and weight gain in pregnant women: A group-based approach.

36. Relationships between Social Supports, Maternal Confidence, Maternal Competence, and Maternal Parenting Stress in the Postpartum Period of Postpartum Women : Multilevel Analysis
37. An Exploratory Study of the Postpartum Stress and its Related Factors
38. A Compare of The Postpartum Depression Related Factors in Early Postpartum Women With or Without Depression.
39. Risk and protective factors for pre- and postnatal bonding.
40. Psychometric properties of the Psychosocial Screen for Cancer-Revised (PSSCAN-R) in Taiwan

s of Preterm Infants .

41. Further psychometric testing and use of the Maternal Confidence Questionnaire
42. Sources of maternal confidence and uncertainty and perceptions of problem-solving competence
43. Maternal confidence, knowledge, and quality of mother – toddler interactions: a preliminary study
44. Maternal confidence in toddlerhood: Its measurement for clinical practice and research
45. Maternal confidence during toddlerhood: Comparing pre-term and full-term groups
46. Comparison of confidence between mothers who breastfed and formula fed their preterm infants
47. The determinants of parenting behavior
48. The determinants of parenting: A process model
49. Self-efficacy: Toward a unifying theory of behavioral change
50. Self-Efficacy-The Exercise of Control
51. Social support as a moderator of life stress
52. Correlates of first-time mothers' postpartum stress
53. Variables related to motherhood in normal primiparous woman
54. Psychosocial features at different periods after childbirth
55. The psychosocial consequences for primiparas and multiparas